

UTERUS ET ANNEXES





PLAN DE L'ETUDE

- INTRODUCTION
 - UTERUS
 - ANNEXES DE L'UTERUS
 - Trompe Utérine.
 - Ovaire.
 - VASCULARISATION ET INNERVATION DE L'UTERUS ET DES ANNEXES
- 

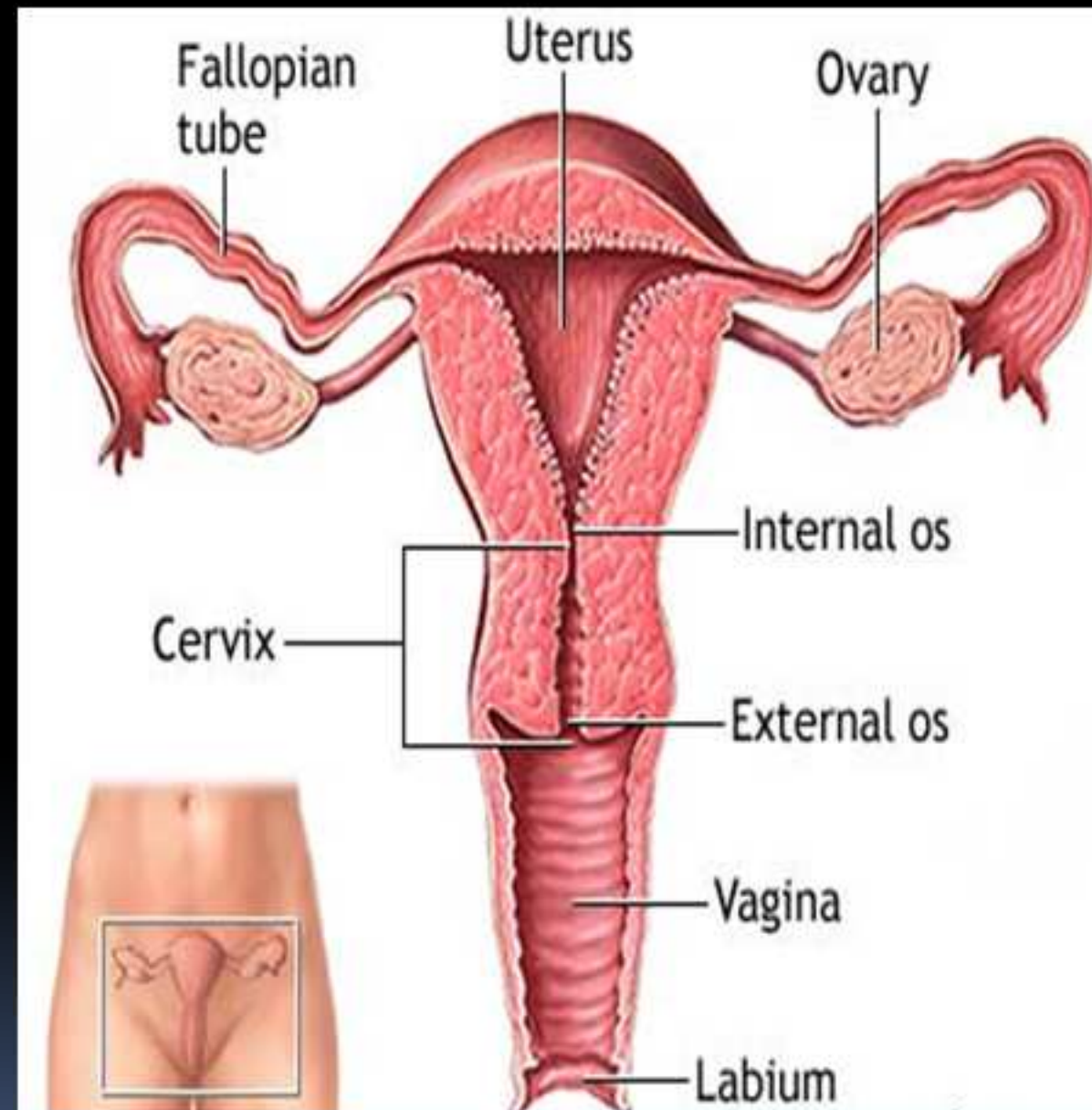


INTRODUCTION

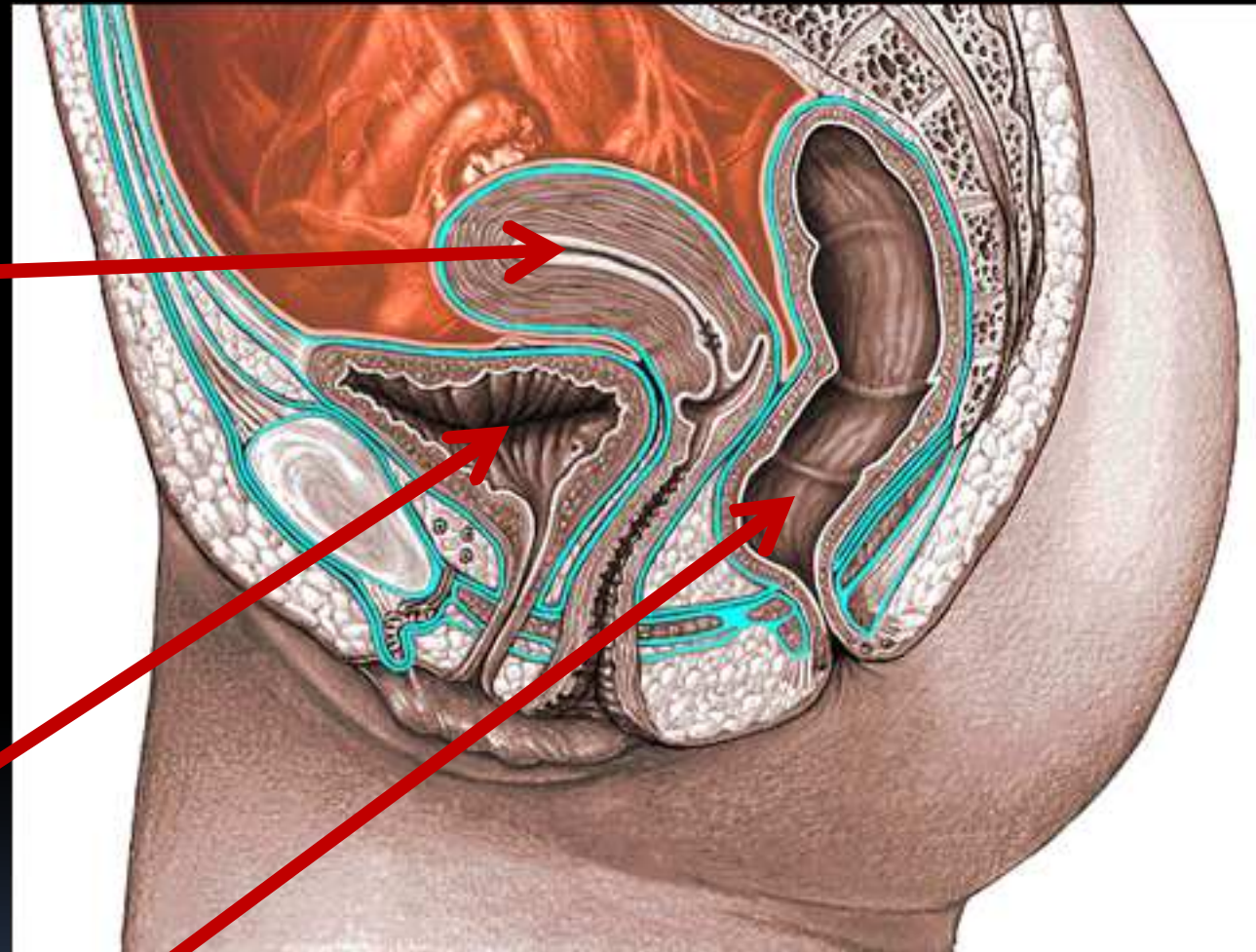


Les organes génitaux internes de la femme sont représentés par:

- L'utérus
- Les annexes de l'utérus (les trompes utérines et les Ovaires)
- Une partie du vagin .



- Ces organes occupent la **loge viscérale moyenne (loge génitale)** de la région pelvienne sous péritonéale.
- Cette loge génitale est située en arrière de la **loge vésicale** et en avant de la **loge rectale**.





UTERUS





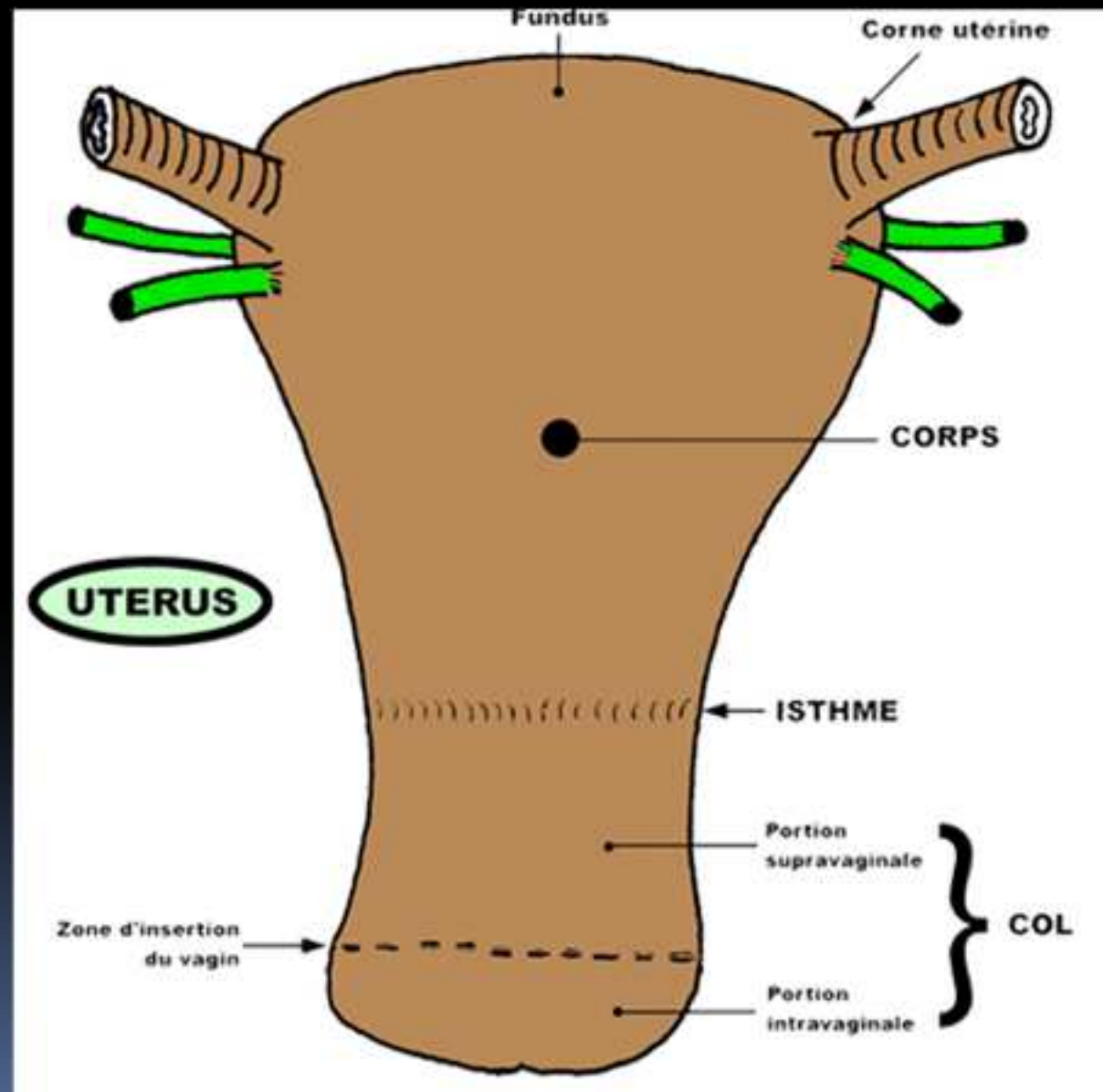
Plan d'étude

- INTRODUCTION
 - ANATOMIE DESCRIPTIVE
 - Configuration extérieure et rapports
 - Configuration intérieure
 - Moyens de Fixité
 - Modifications de l'utérus au cours de la grossesse.
- 

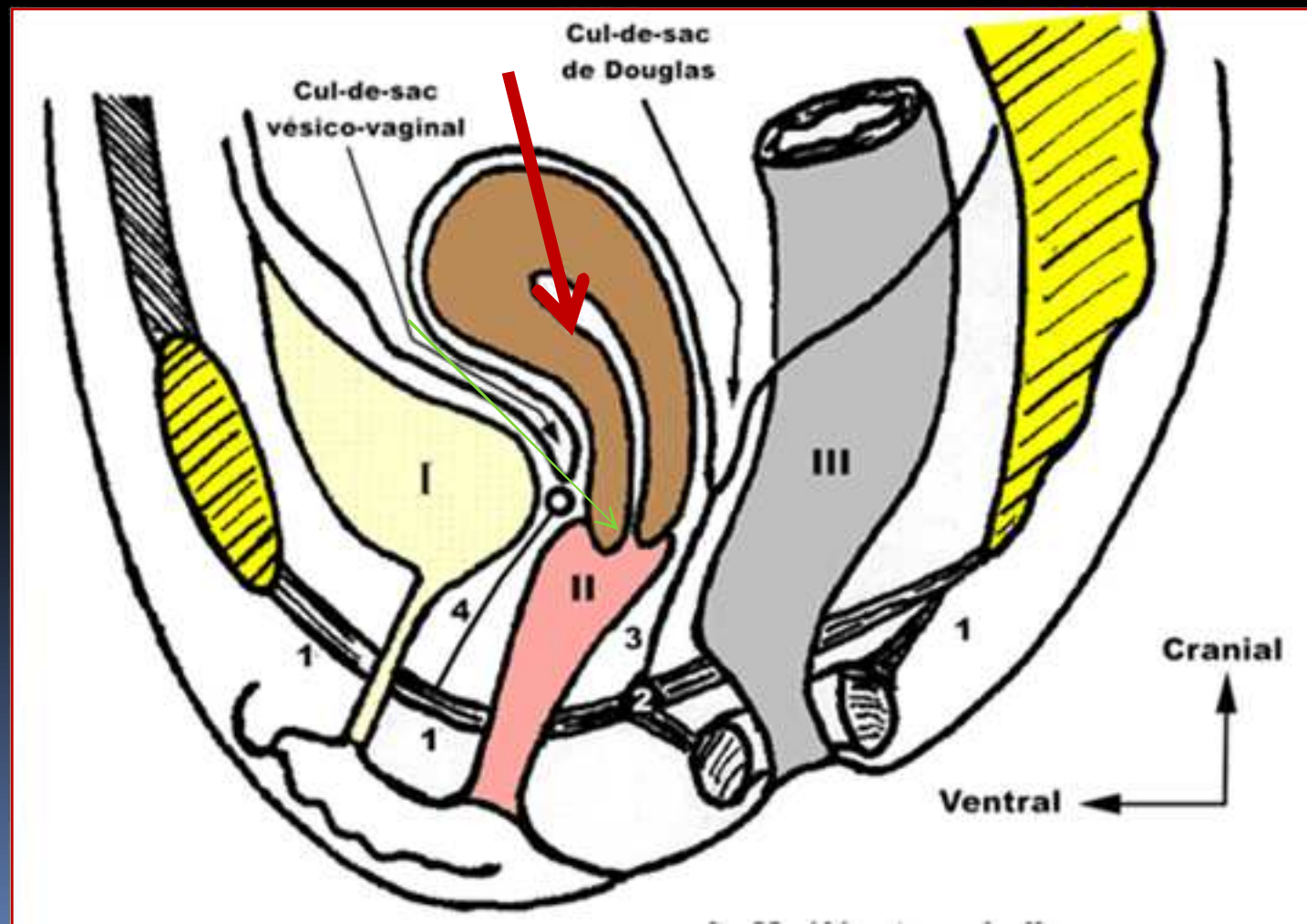


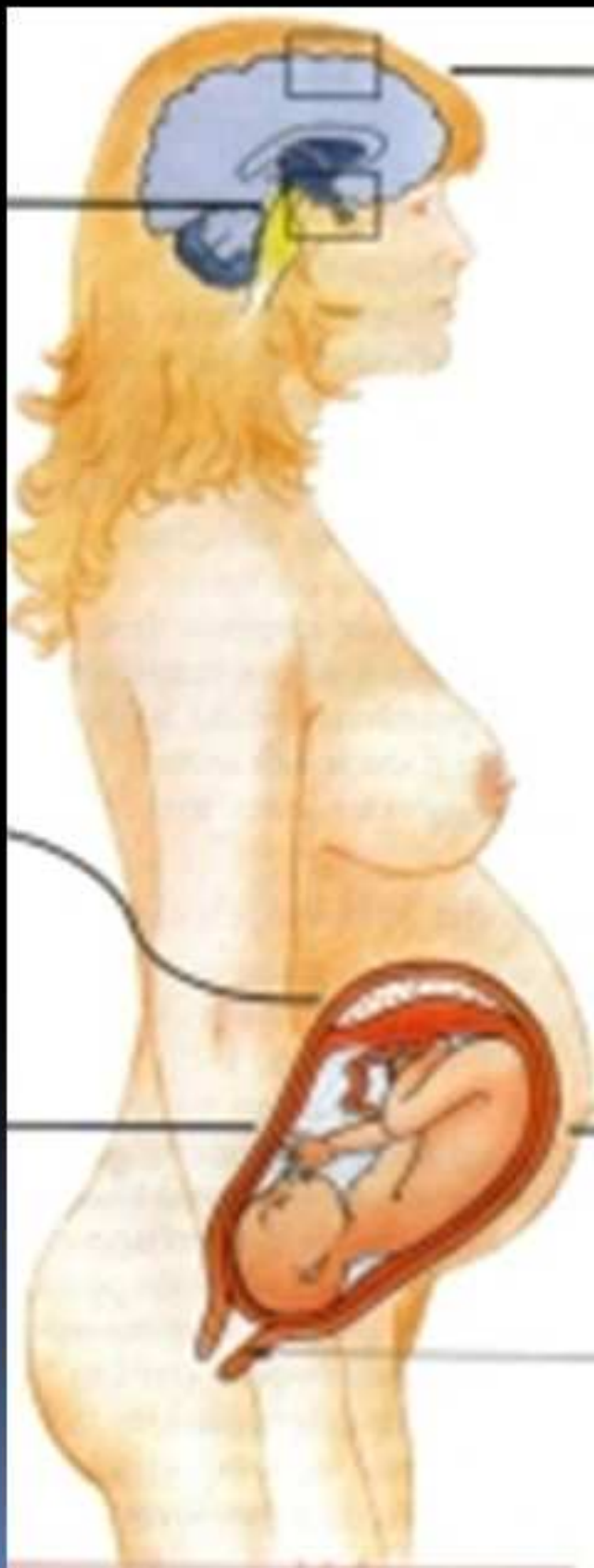
INTRODUCTION

- L'utérus est **l'organe de la gestation**, appartenant à l'appareil génital Féminin.
- C'est un muscle lisse, creux, dont la cavité est tapissée d'une muqueuse, siège de modifications cycliques au cours de la vie génitale.



- Il présente d'importantes transformations morphologiques et fonctionnelles au cours de la grossesse.
- C'est un organe médian et impair situé dans la cavité pelvienne.





- Destiné à contenir l'œuf fécondé pendant son évolution et l'expulser après son complet développement (foetus ou nouveau né).



ANATOMIE DESCRIPTIVE

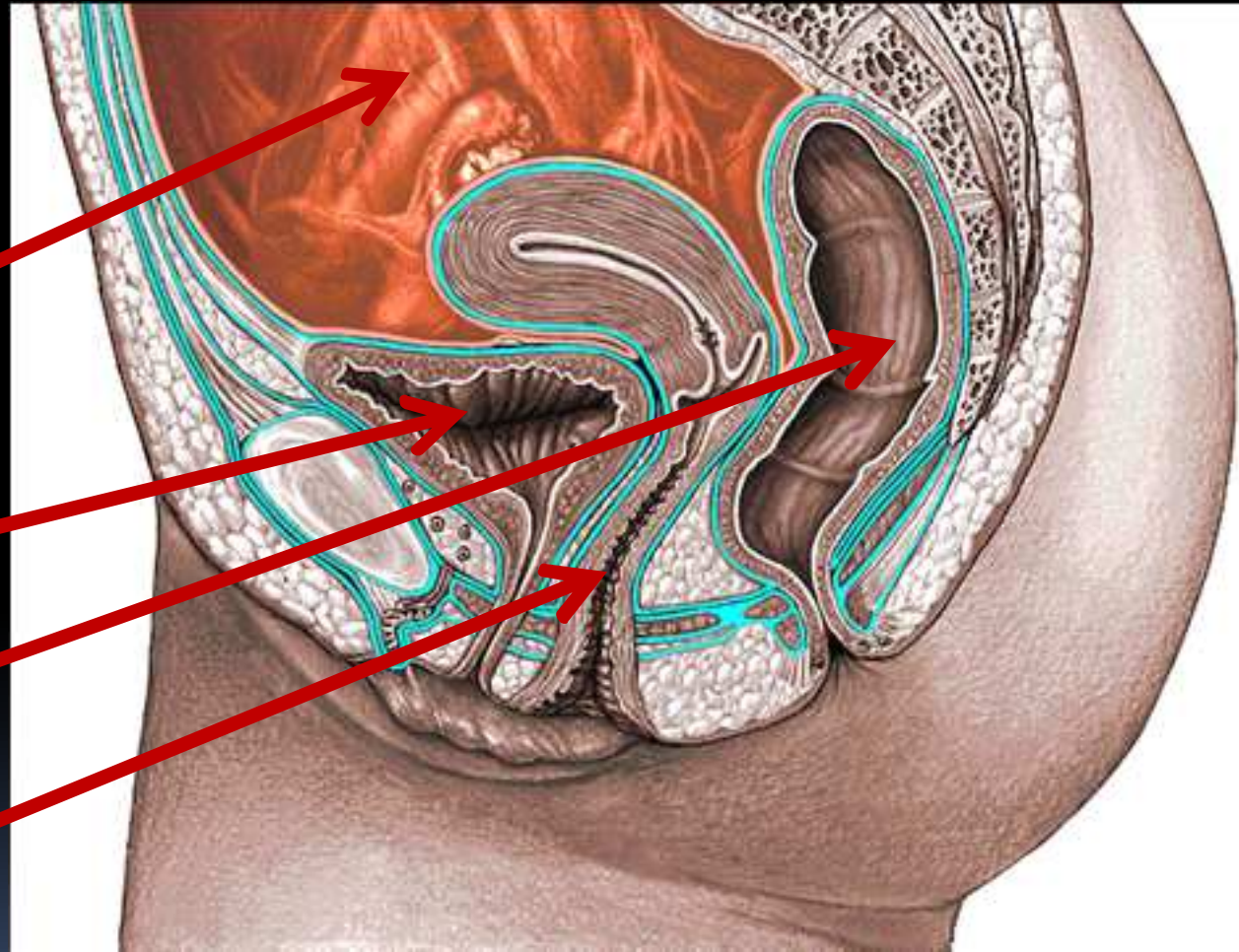


Situation

ANATOMIE DESCRIPTIVE

■ L'utérus est situé dans la cavité pelvienne:

- Au-dessous des anses intestinales et du colon pelvien.
- En arrière de la vessie.
- En avant du rectum.
- Au-dessus du vagin.



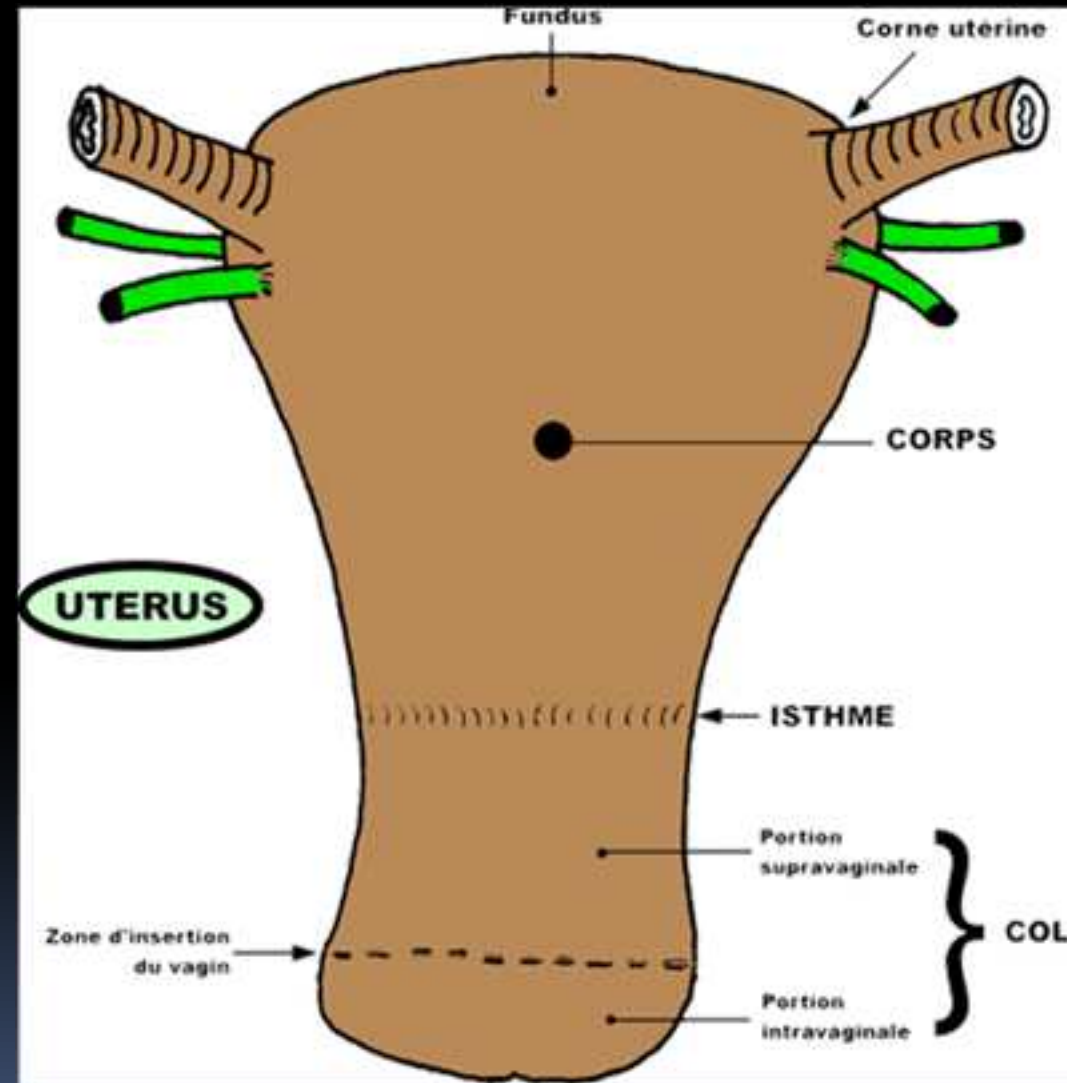


Consistance, Forme et dimensions

**ANATOMIE
DESCRIPTIVE**



- L'utérus est de consistance ferme.
- Il présente la forme d'un cône tronqué, à base supérieure et à sommet inférieur.
- Il présente un étranglement à la partie moyenne : c'est **l'isthme utérin** qui divise l'organe en deux parties :
 - L'une supérieure **le corps utérin**.
 - l'autre inférieure **le col utérin**.



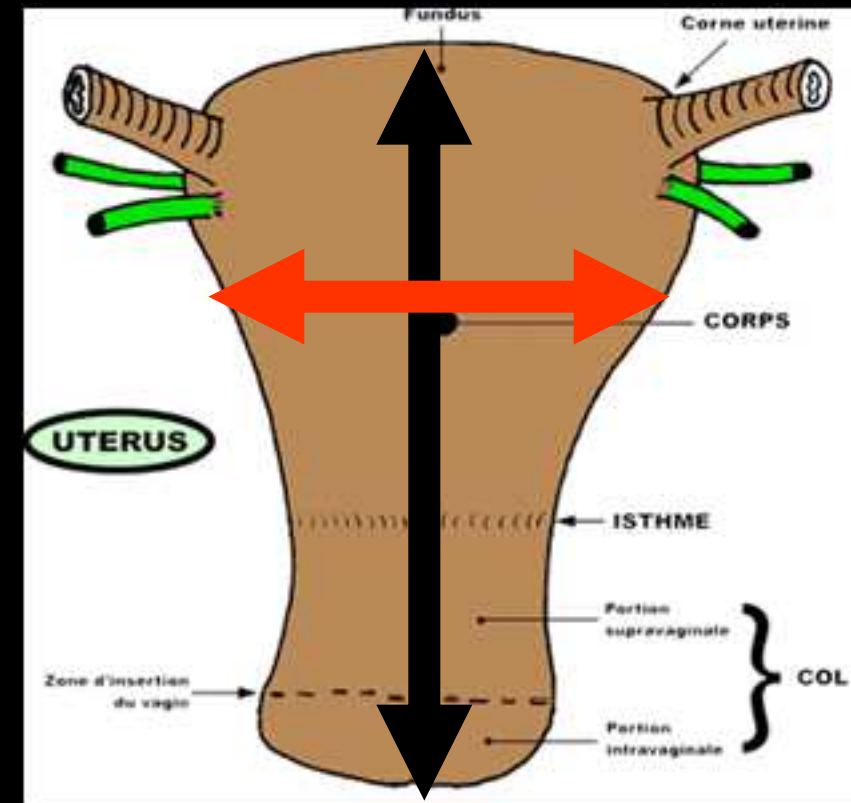


Dimensions

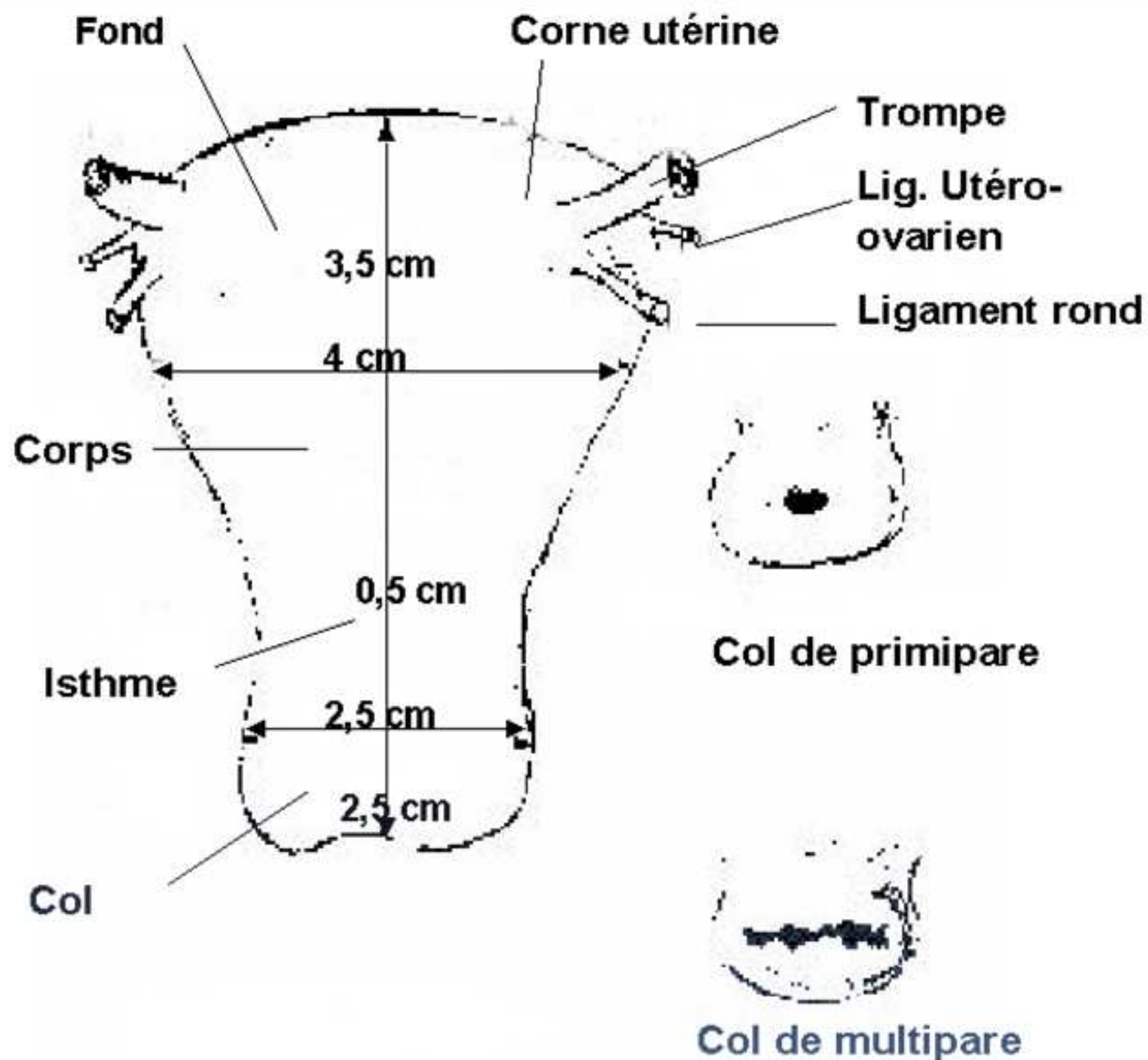
ANATOMIE DESCRIPTIVE

Quelques dimensions à l'état normal

- **Chez la nullipare :**
 - **Longueur :** 6 à 7 cm :
 - 3,5 cm au niveau du corps.
 - 1/2 cm au niveau de l'isthme.
 - 2,5 au niveau du col.
 - **Largeur :**
 - 4 cm au niveau du fond utérin.
 - 2 cm au niveau du col.
 - **Épaisseur :** 2 cm.



- 
- 
- **Chez la multipare :** l'utérus prend un aspect globuleux et l'isthme tend à s'effacer.
 - **Longueur :** 7 à 8 cm:
 - 5 cm au niveau du corps.
 - 3 cm au niveau du col.
 - **Largeur :** 5 cm au niveau du fond utérin
 - **Épaisseur :** 3 cm



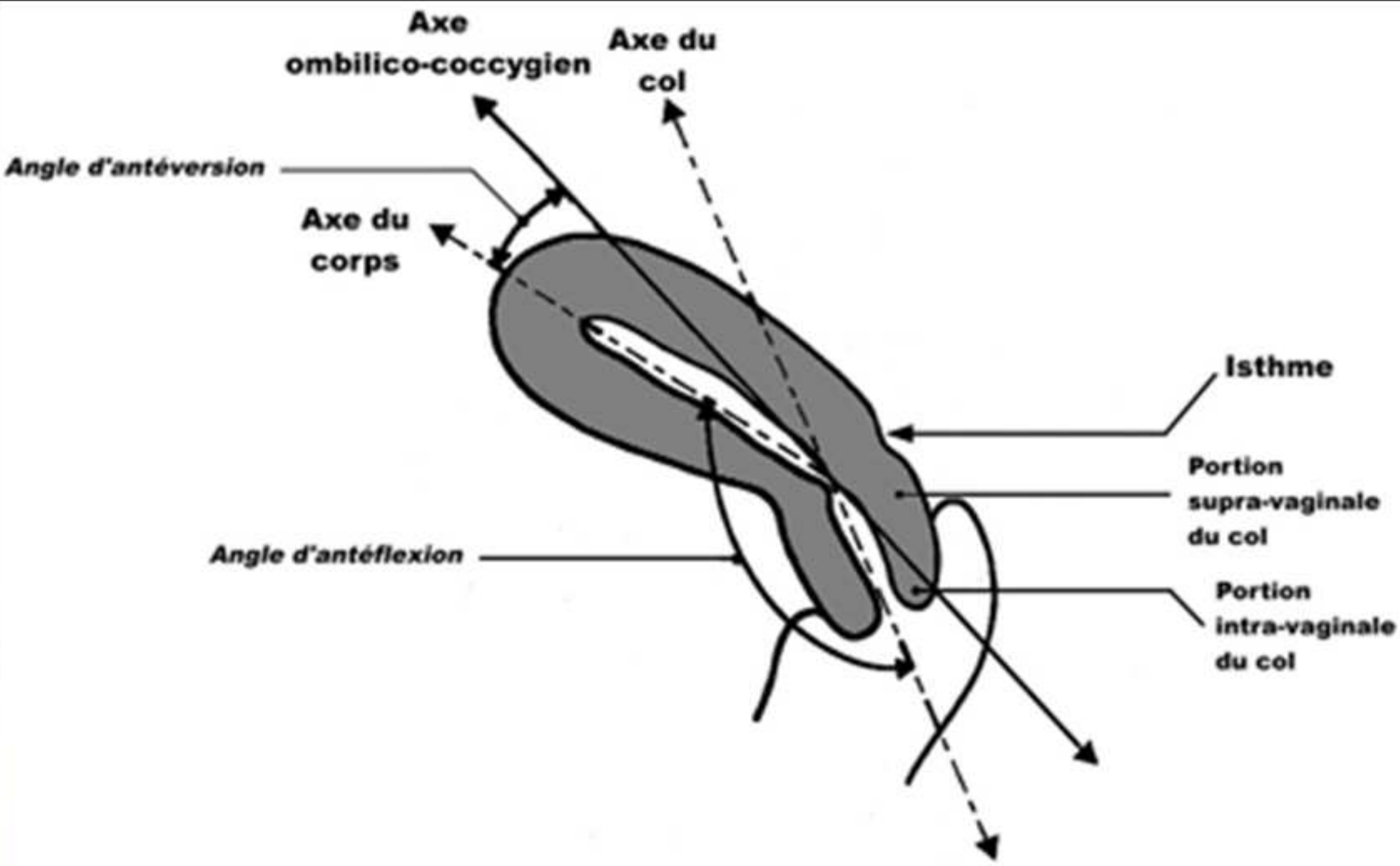
Forme - dimensions



Direction et orientation

**ANATOMIE
DESCRIPTIVE**

- 
- 
- Dans son ensemble l'utérus est normalement incliné de bas en haut et d'arrière en avant, on dit : Il est à la fois **anté-fléchi** et **anté-versé**.
 - L'anté-flexion : l'angle entre le corps et le col utérins ouvert en bas et en avant varie entre $100 - 140^{\circ}$ (110 en moyenne).
 - L'anté-version : le fond utérin en avant, le col utérin en arrière par rapports à l'axe du bassin.



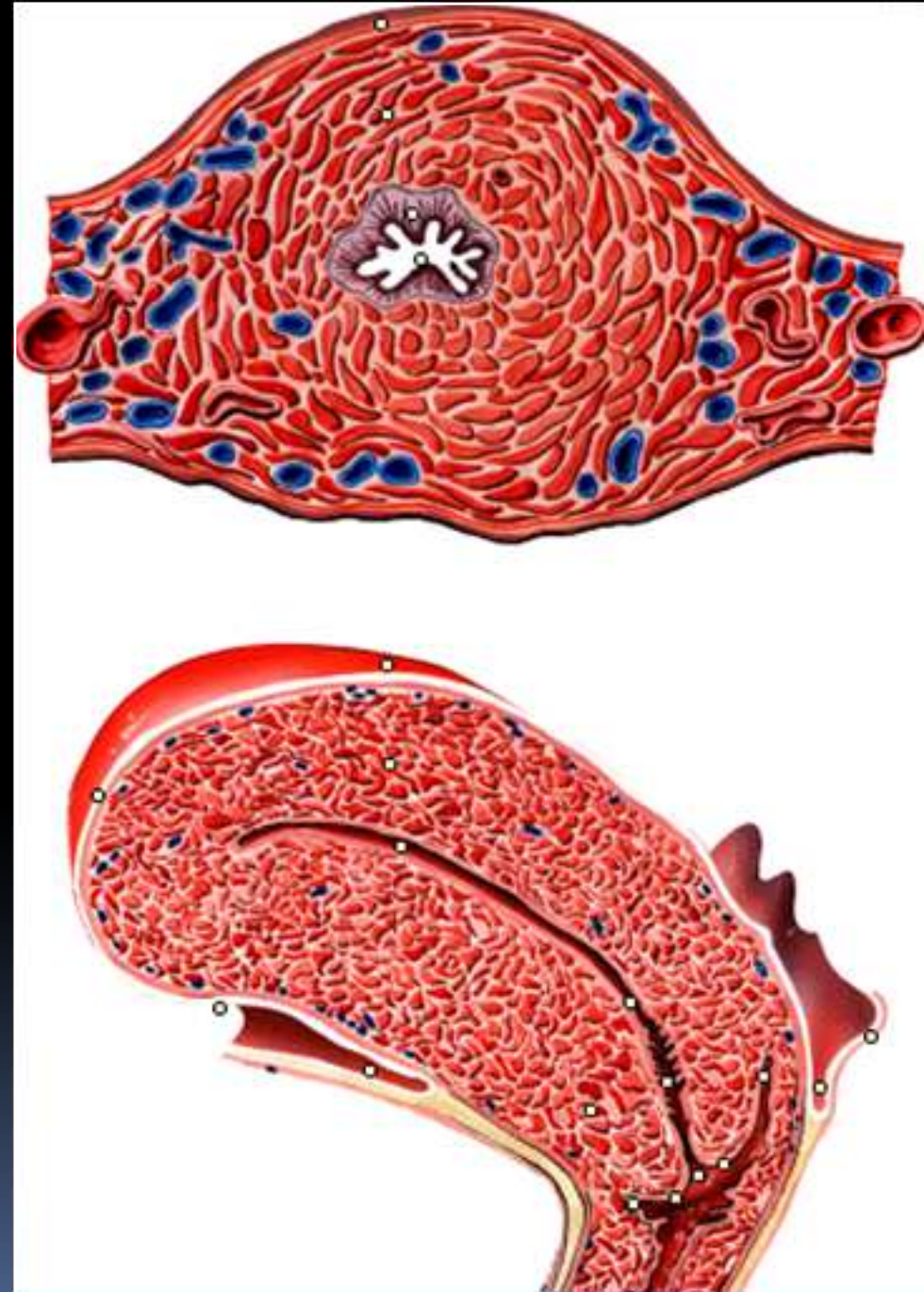
- 
- Autres positions possibles :
 - Rétroversion : Le fond bascule en arrière
 - Rétroflexion : Angle entre le col et le corps est ouvert en arrière .
 - Torsion sur l'axe.
- 



Structure

ANATOMIE
DESCRIPTIVE

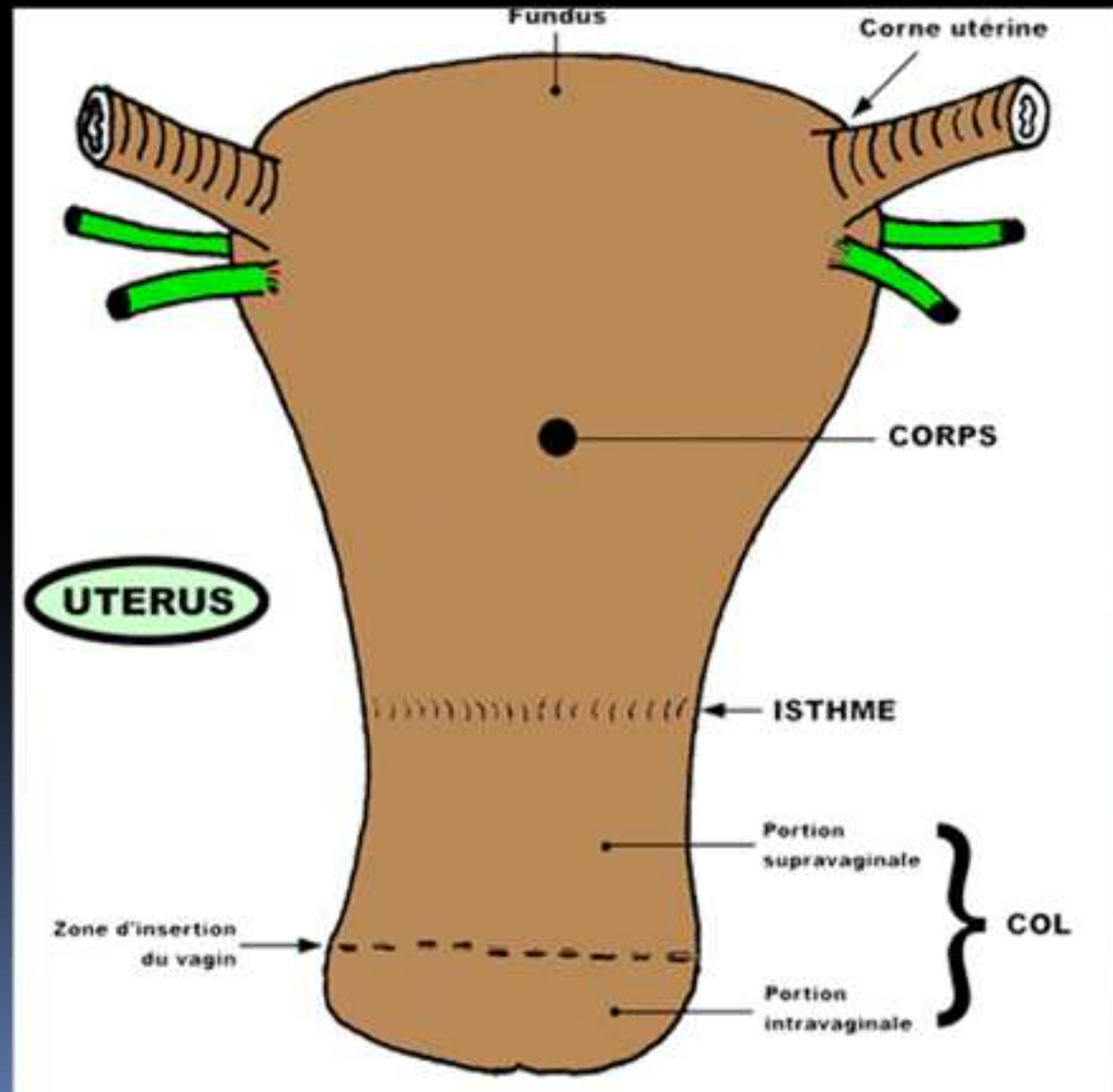
- La paroi utérine est formée de 3 couches qui sont de la surface à la profondeur :
 - La **séreuse péritonéale** ou **périmètre** : existe uniquement au niveau du corps. L'isthme et le col sont dépourvus de péritoine.
 - La **muscleuse** ou **myomètre** : très épaisse, elle est constituée de 3 couches : externe, moyenne et interne. Il s'agit d'un muscle lisse à commande involontaire.
 - La **muqueuse** : mince et friable, elle constitue l'endomètre au niveau du corps.





CONFIGURATION EXTERIEURE ET RAPPORTS

- L'utérus présente à décrire 3 segments :
 - Corps
 - Isthme
 - Col



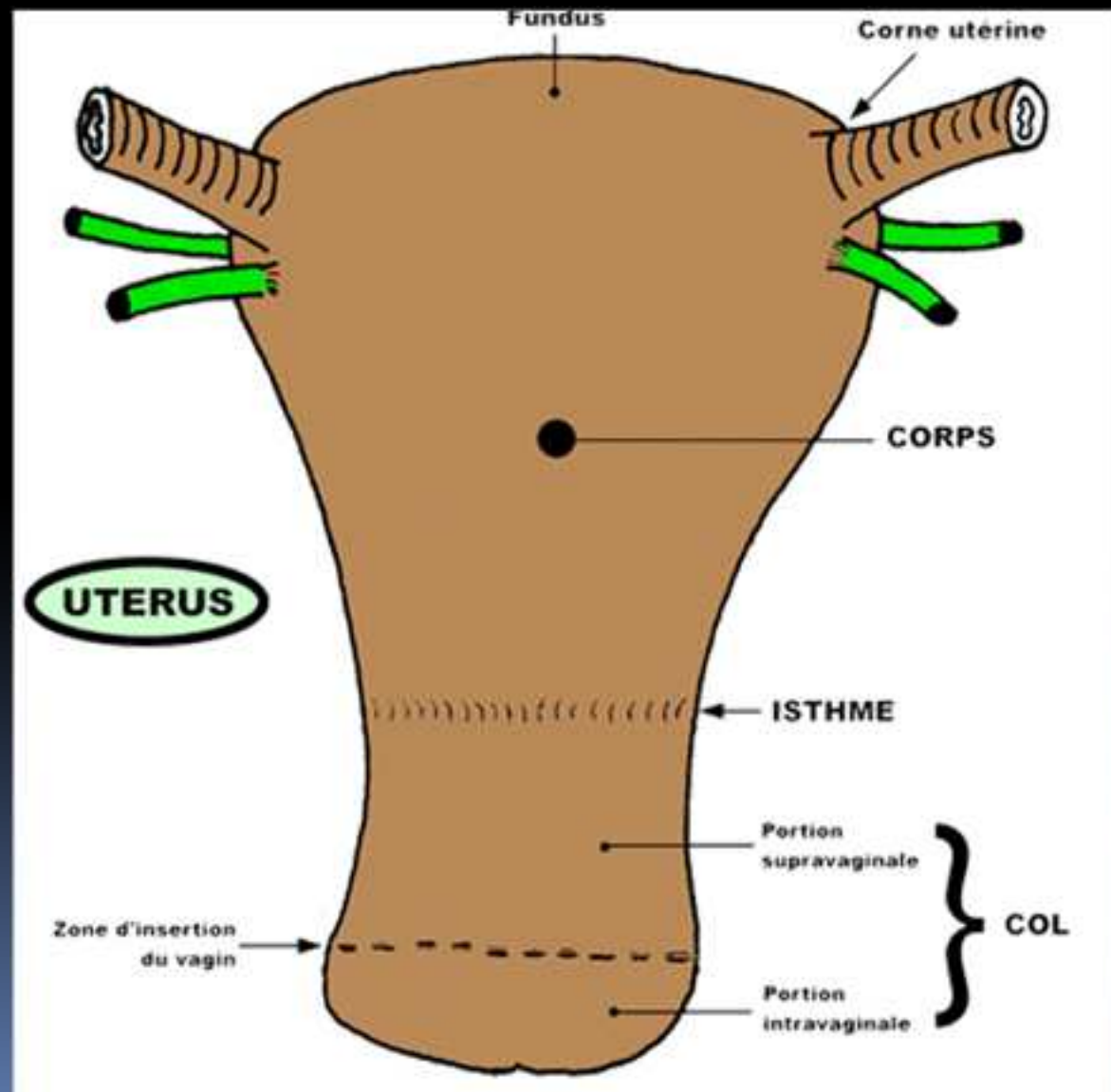


Corps

CONFIGURATION EXTERIEURE
ET RAPPORTS

Le corps

- De forme triangulaire.
- Il présente
 - Deux faces.
 - Trois angles.
 - Trois bords.





Faces

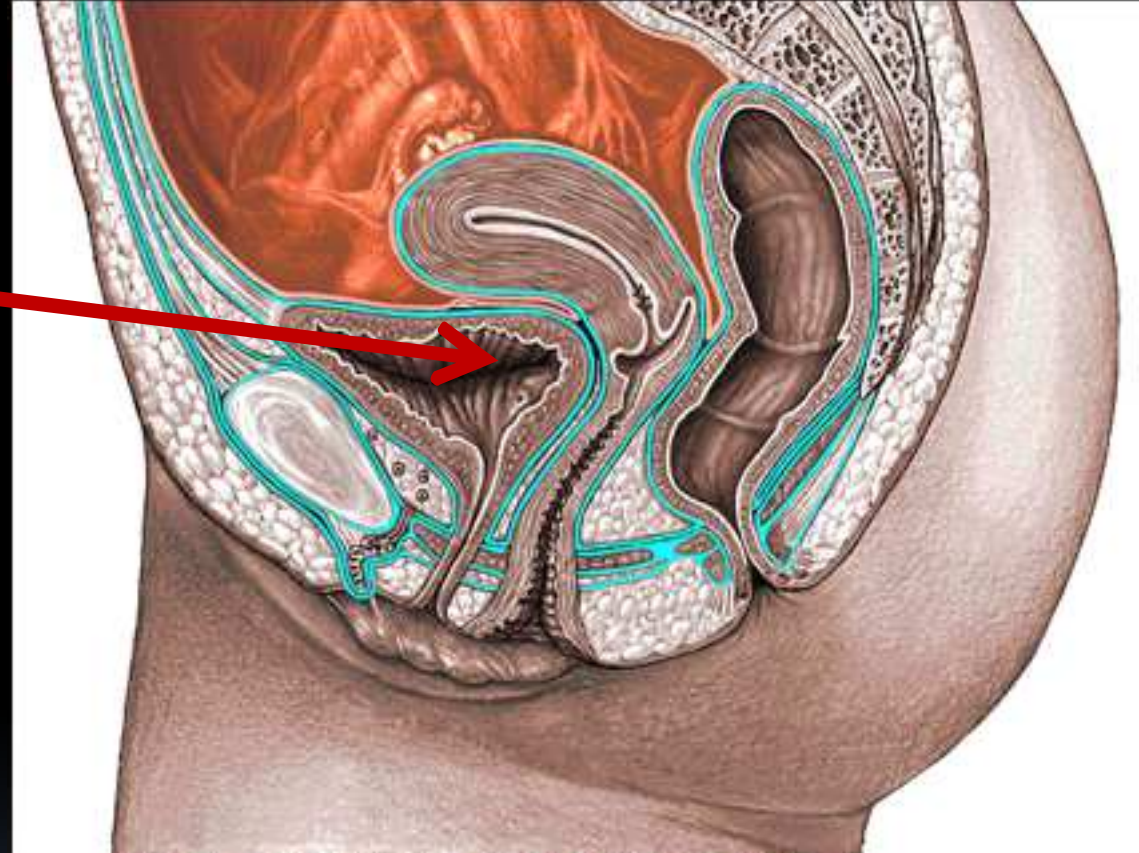
CONFIGURATION EXTERIEURE
ET
RAPPORTS

■ La face antérieure ou antéro inférieure est en rapport avec:

■ la vessie

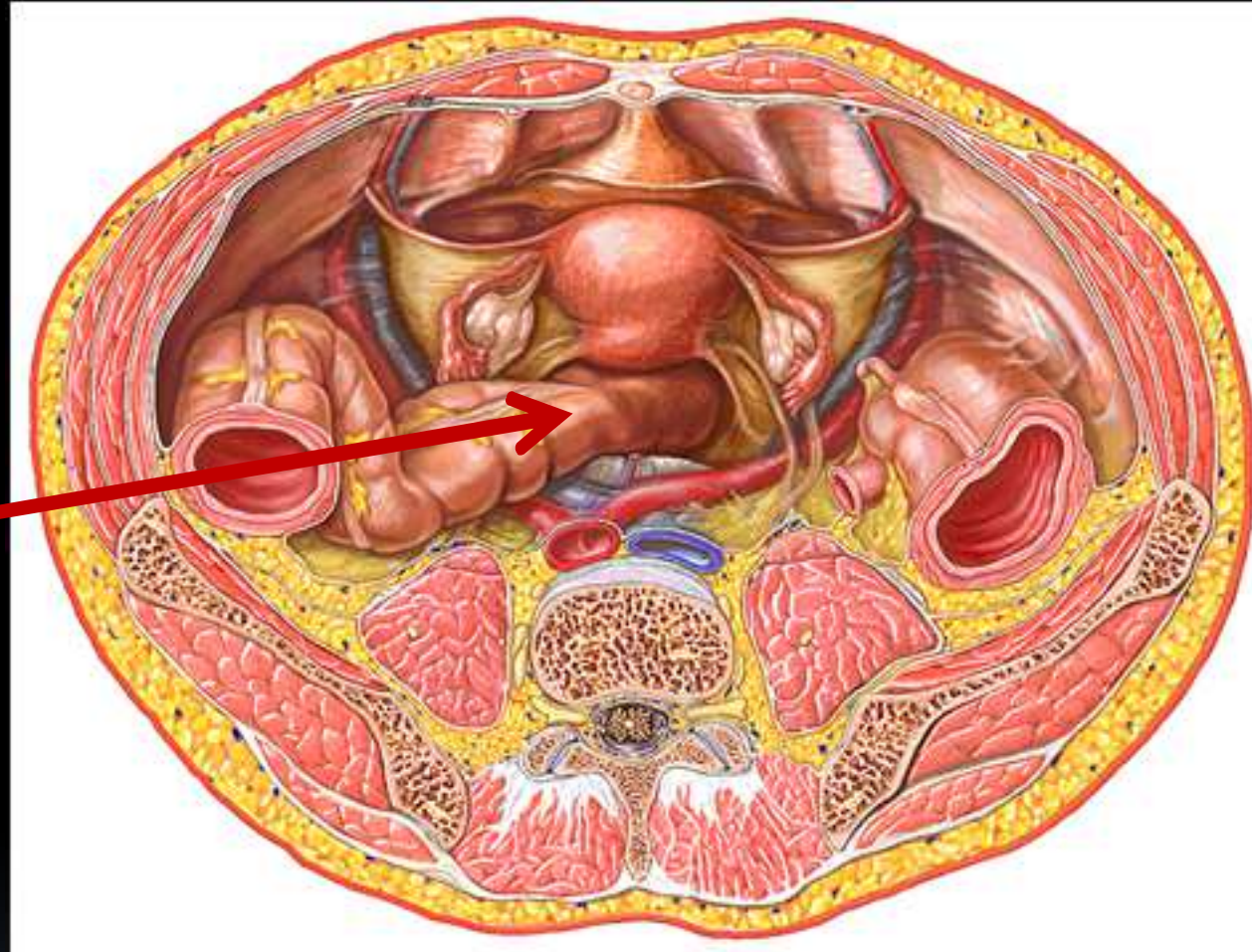
dont elle est séparée par le péritoine qui forme le cul de sac vésico – utérin.

(le péritoine s'arrête au niveau de l'isthme)



La face postérieure ou postéro – supérieure : en rapports avec

- Les anses intestinales
- Le colon pelvien,
- Recouverte par le péritoine (qui descend jusqu'au vagin) qui la sépare du rectum formant le cul de sac de Douglas.





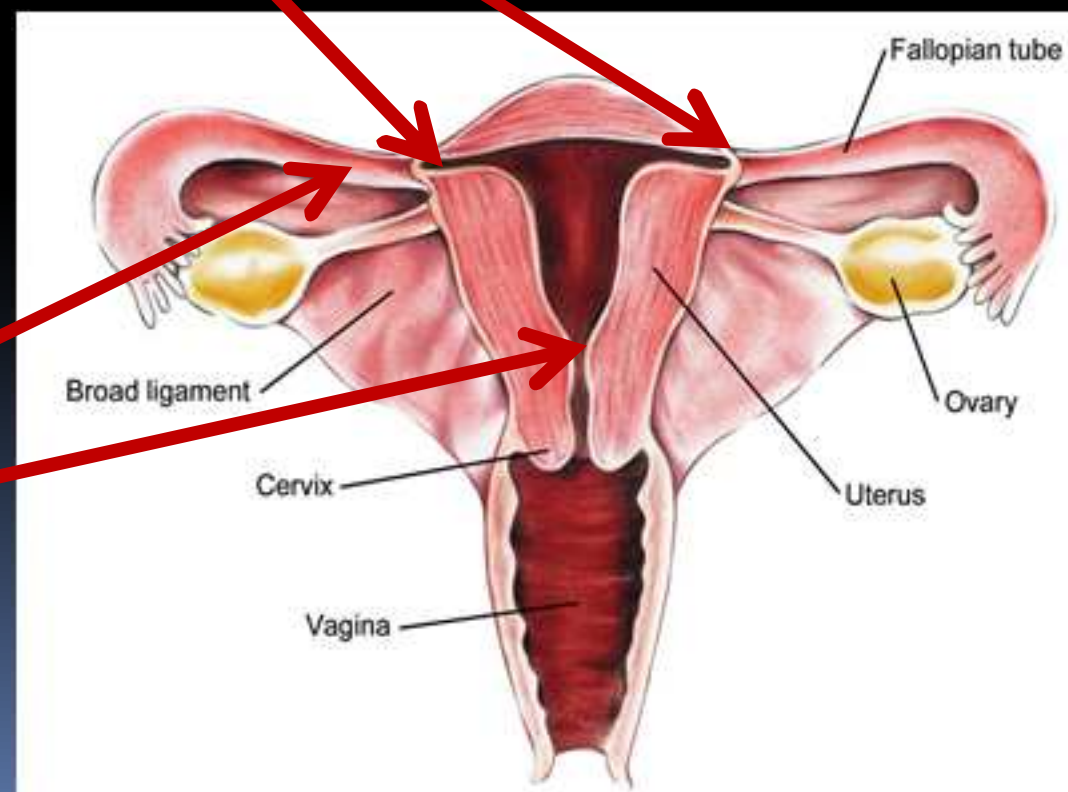
Angles

CONFIGURATION EXTERIEURE ET RAPPORTS

- Deux angles latéraux:

- l'un droit et l'autre gauche appelés également cornes.
- De chaque corne partent les ligaments ronds et utéro-ovariens.
- Chaque corne se continue avec une trompe utérine.

- L'angle inférieur se confond avec l'isthme utérin

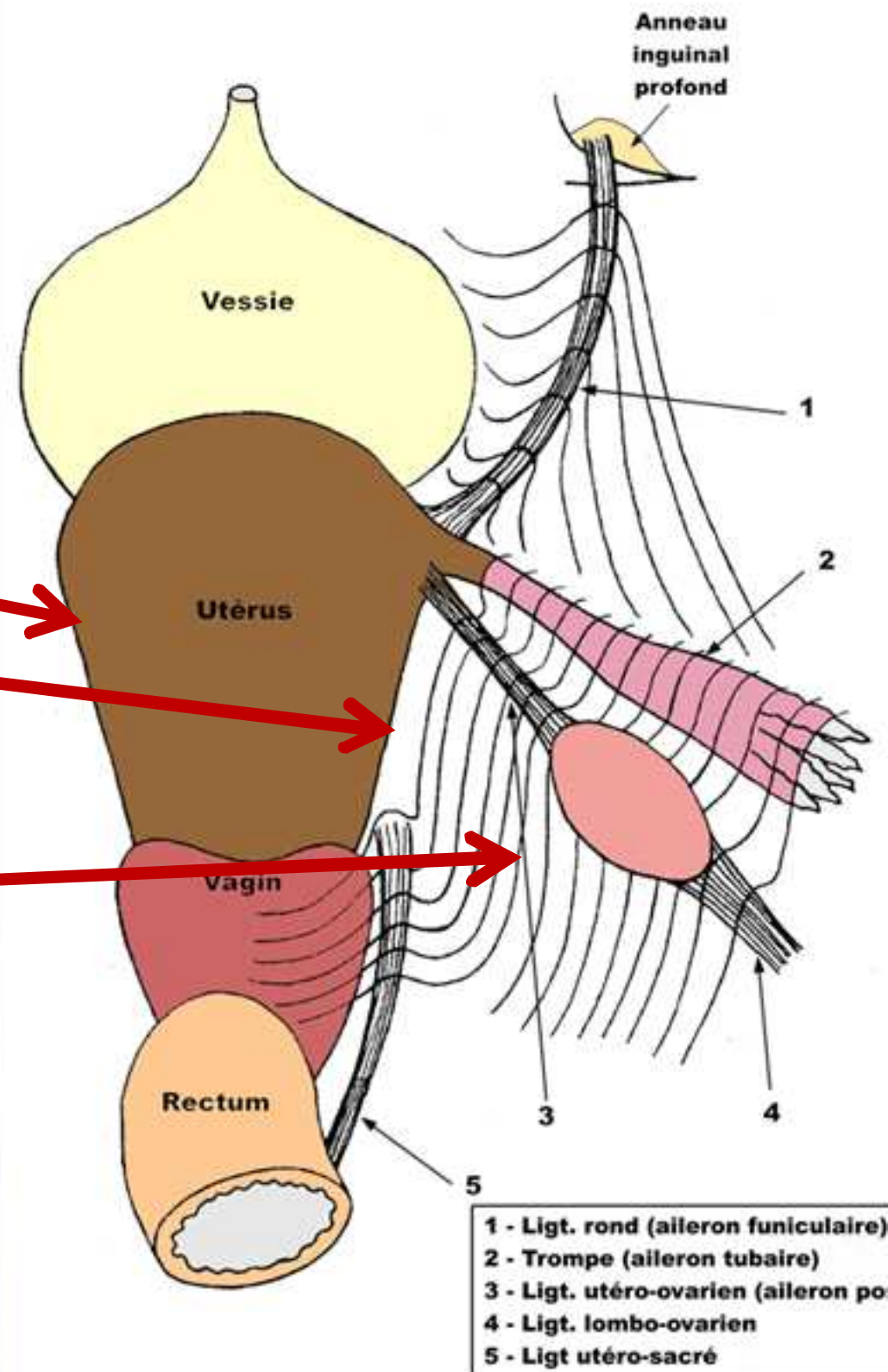




Bords

**CONFIGURATION EXTERIEURE
ET RAPPORTS**

- Deux bords latéraux:
 - Un bord droit.
 - Un bord gauche.
 en rapports avec les **ligaments larges**.
- Un bord supérieur ou base.



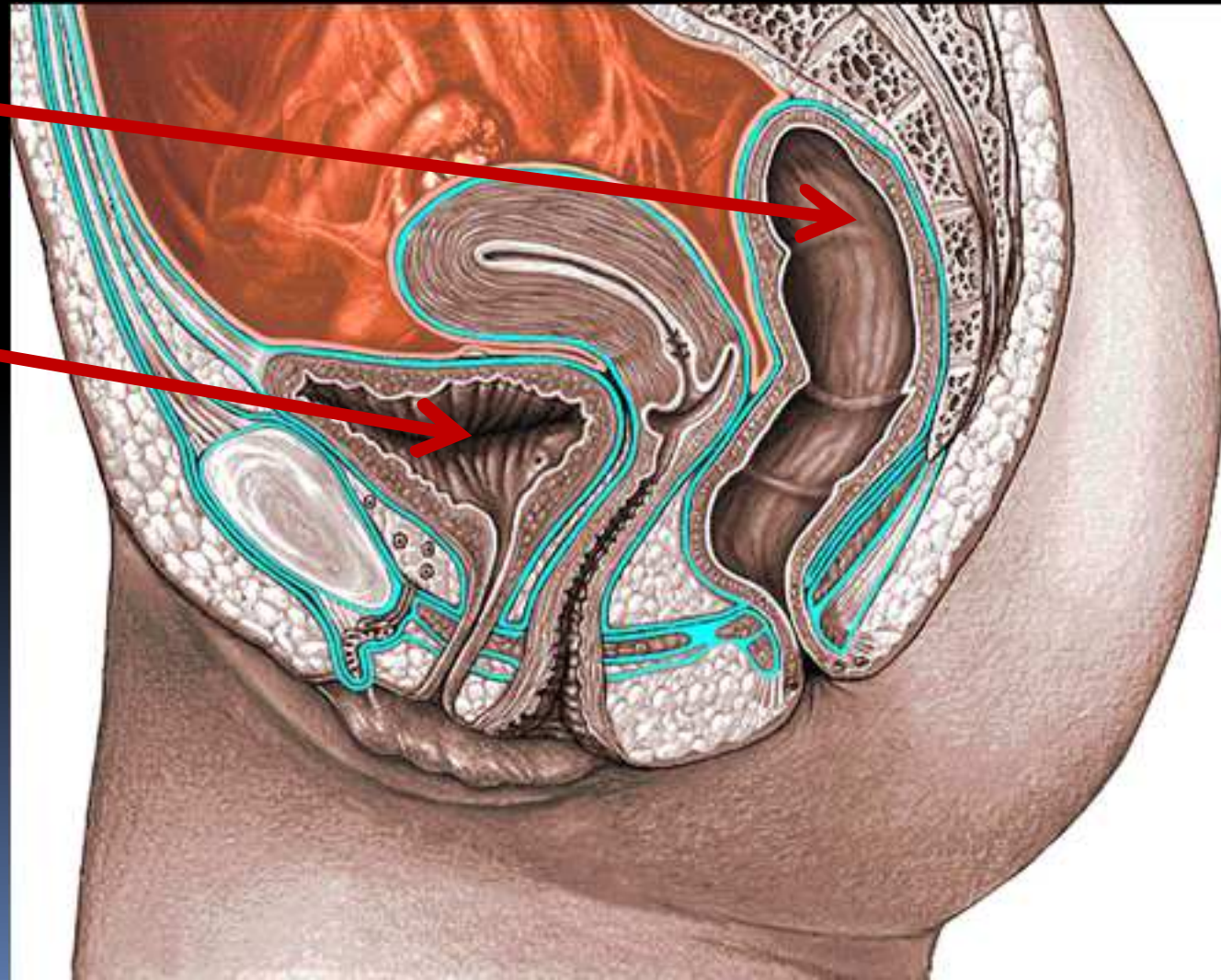
VUE DORSO-CRANIALE



Isthme utérin

**CONFIGURATION EXTERIEURE
ET RAPPORTS**

- L'isthme utérin répond à:
 - Le rectum en arrière.
 - La vessie en avant





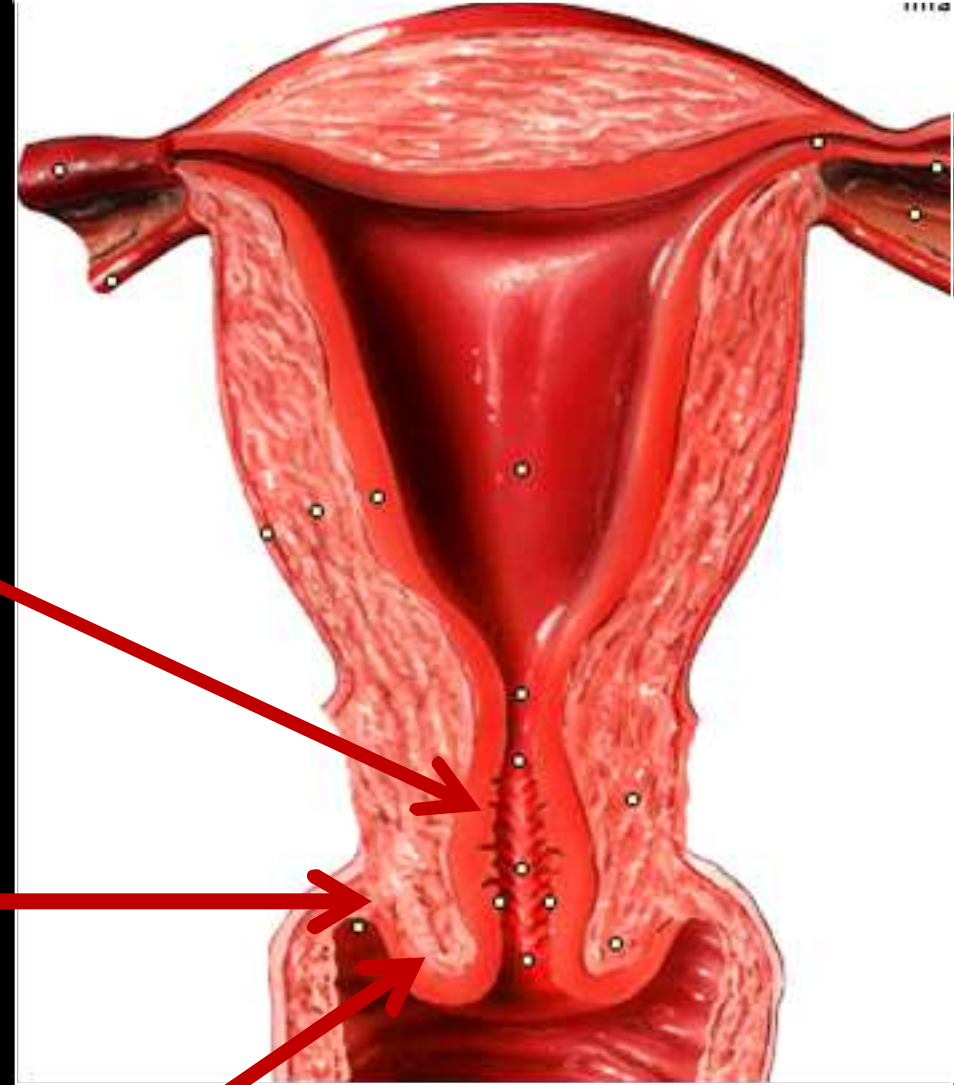
col utérin



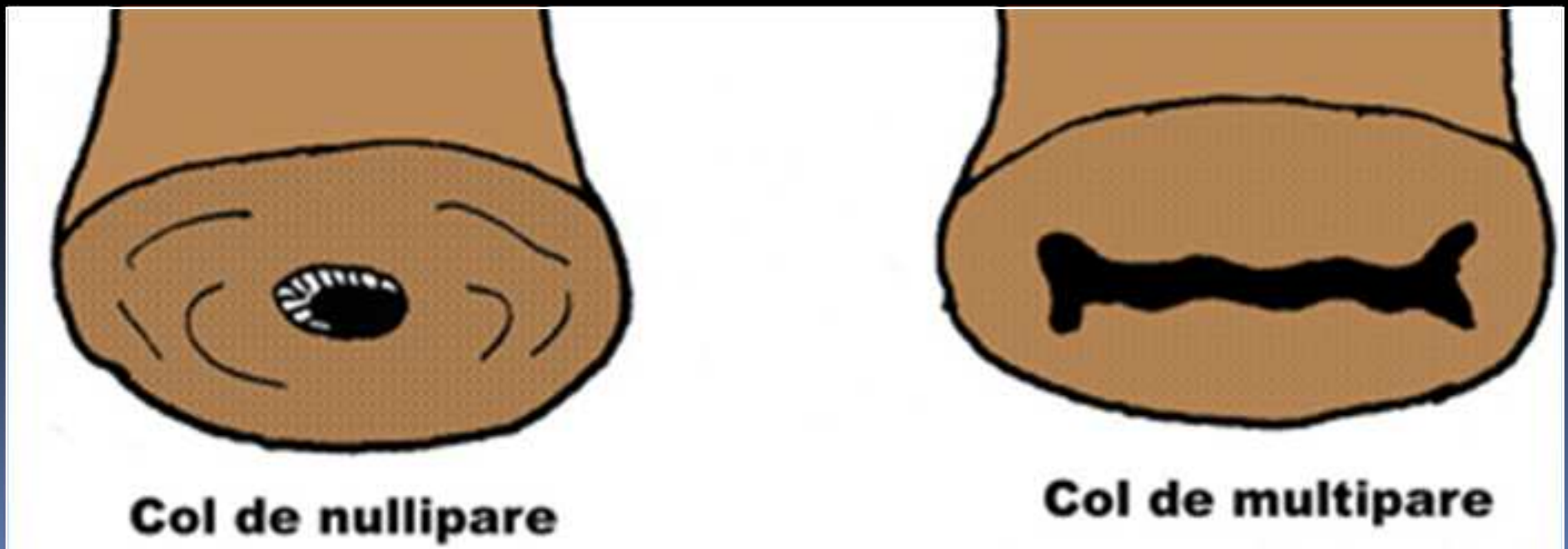
CONFIGURATION EXTERIEURE
ET RAPPORTS

Le col utérin présente à décrire trois segments :

- Segment **sus vaginal** : présente les mêmes rapports que ceux du corps et l'isthme.
- Segment **vaginal** : correspond à la ligne d'insertion du vagin sur le col
- Segment **intra – vaginal** : appelé le **museau de tanche**.



- Les caractères du **museau de tanche** diffèrent selon la **parité** :
 - Chez la **nullipare** : le col est de consistance ferme, l'orifice cervical externe est circulaire.
 - Chez la **primipare** : le col est moins consistant, l'orifice cervical externe s'allonge transversalement.
 - Chez la **multipare** : le col est encore moins consistant, l'orifice cervical externe est large, il peut atteindre 1,5 cm.

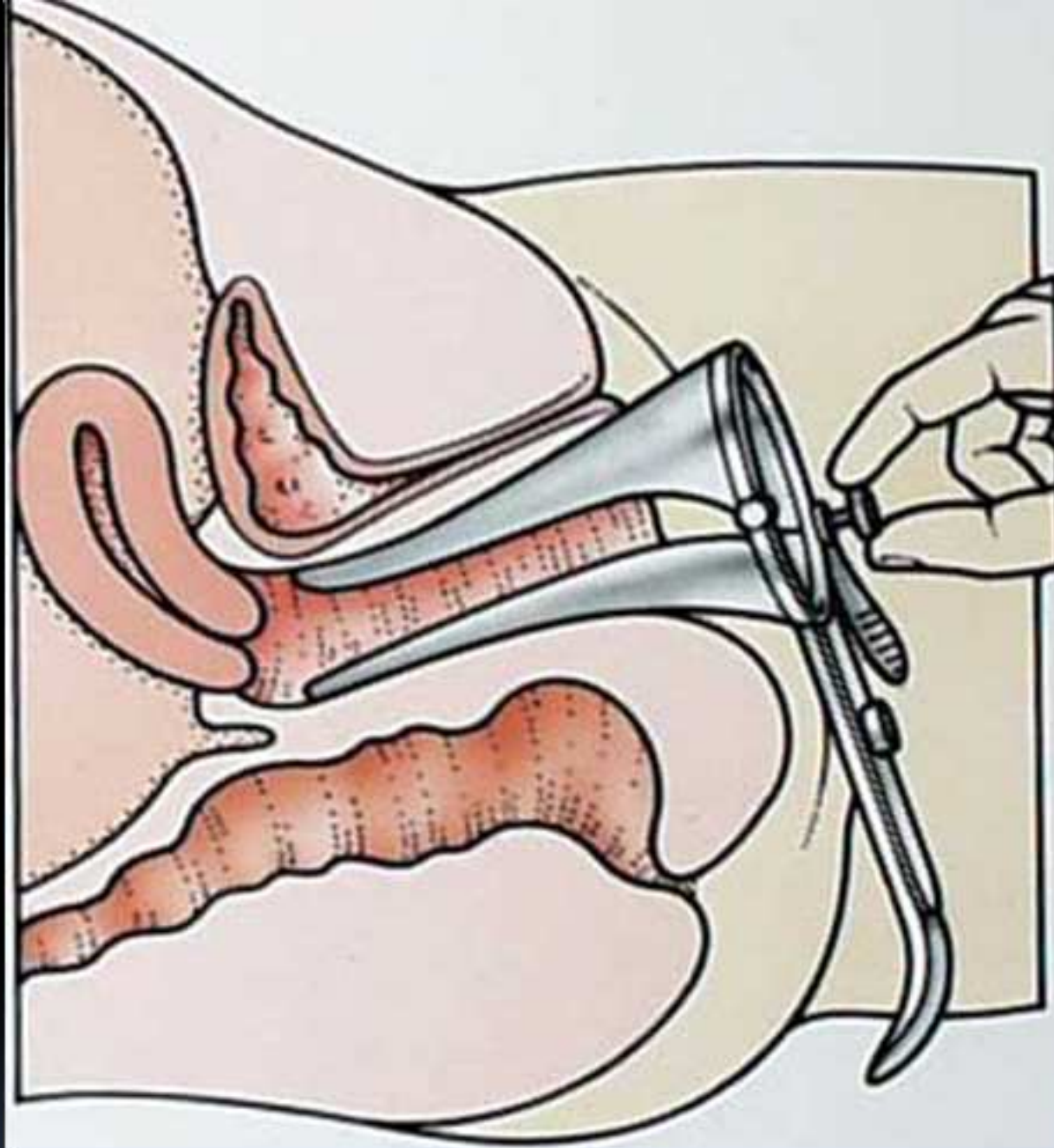


INTERET PRATIQUE

- Le museau de tanche présente un intérêt pratique:
 - **En gynécologie** : grâce à la pose d'un spéculum gynécologique on peut examiner le col utérin par voie vaginale et repérer les lésions inflammatoires ou tumorales, et en pratiquant des frottis cervico – vaginaux (F.C.V) on peut diagnostiquer les cancers du col utérin.
 - **En obstétrique** : l'état du col et son orifice conditionne le travail, le col s'efface et se dilate avant et pendant le travail de l'accouchement .

**Touché
vaginal**





Pose d'un spéculum

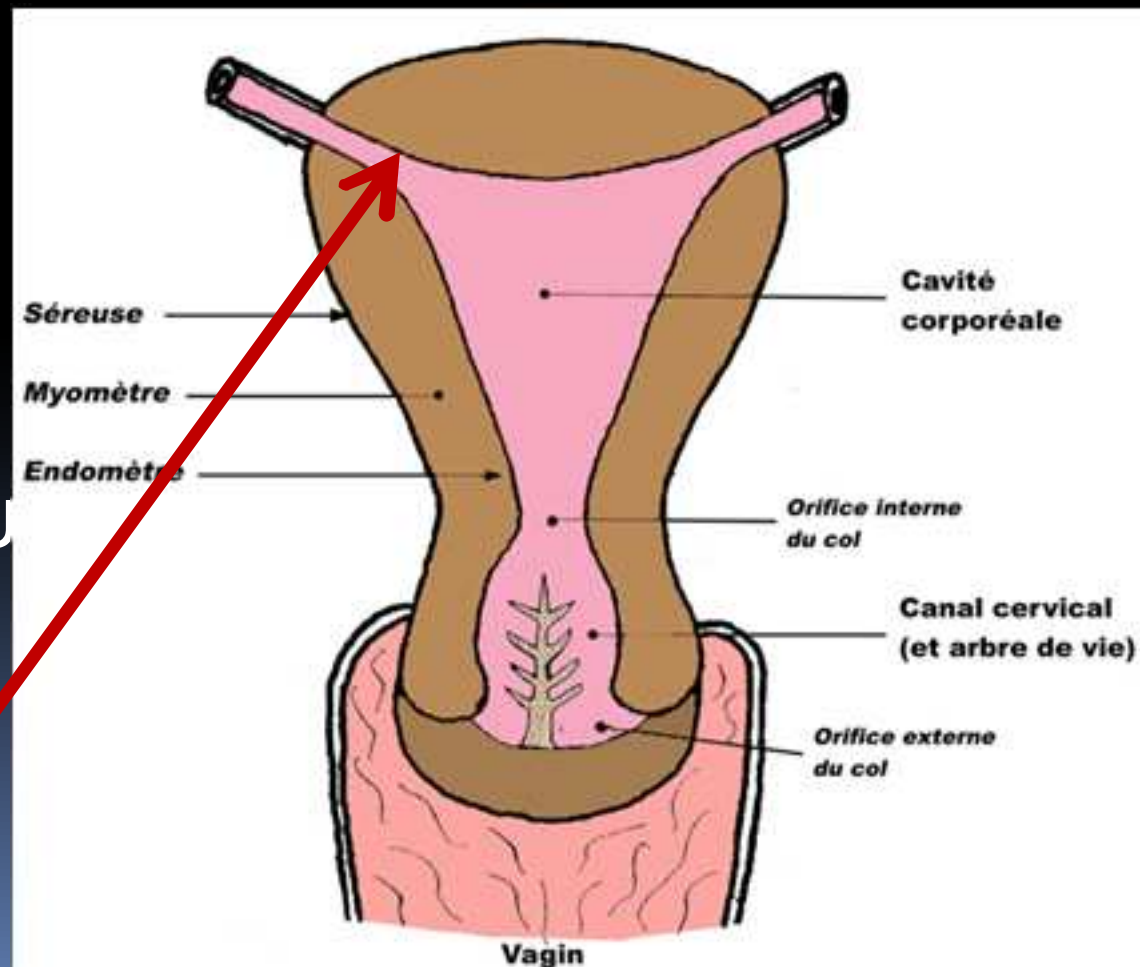


Spéculum

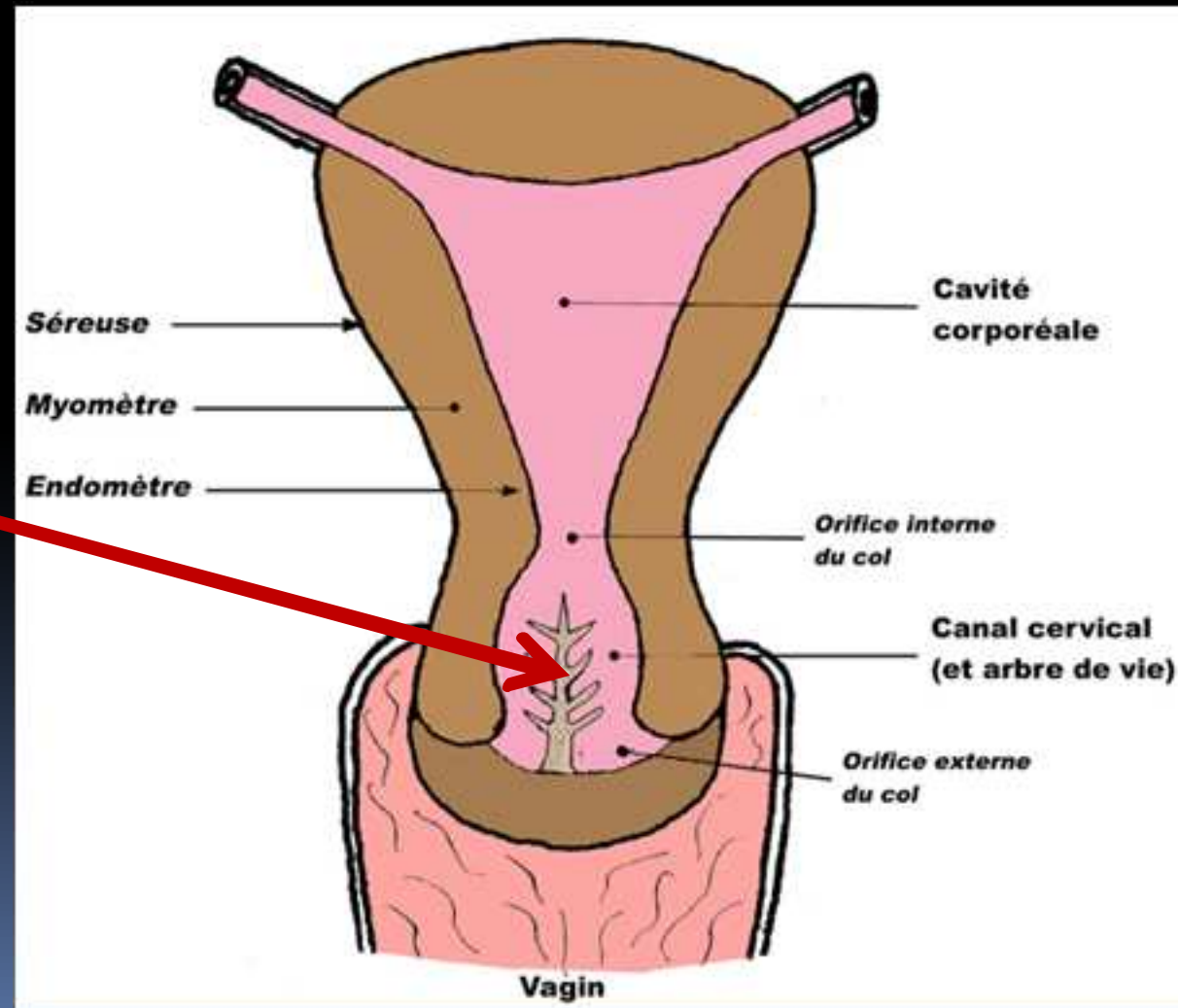


CONFIGURATION INTERIEURE

- La **cavité utérine** peut être mise en évidence sur le vivant par **l'hystérographie** qui montre que cette cavité occupe le col et le corps.
- Au niveau du corps, la cavité s'ouvre de chaque côté (au niveau des cornes utérines) par **l'ostium utérinum** des trompes.



- Au niveau du col, la cavité présente et sur chaque paroi une saillie longitudinale d'où partent des plis palmés : l'ensemble constitue « **l'arbre de vie** ».



MOYENS DE FIXITE

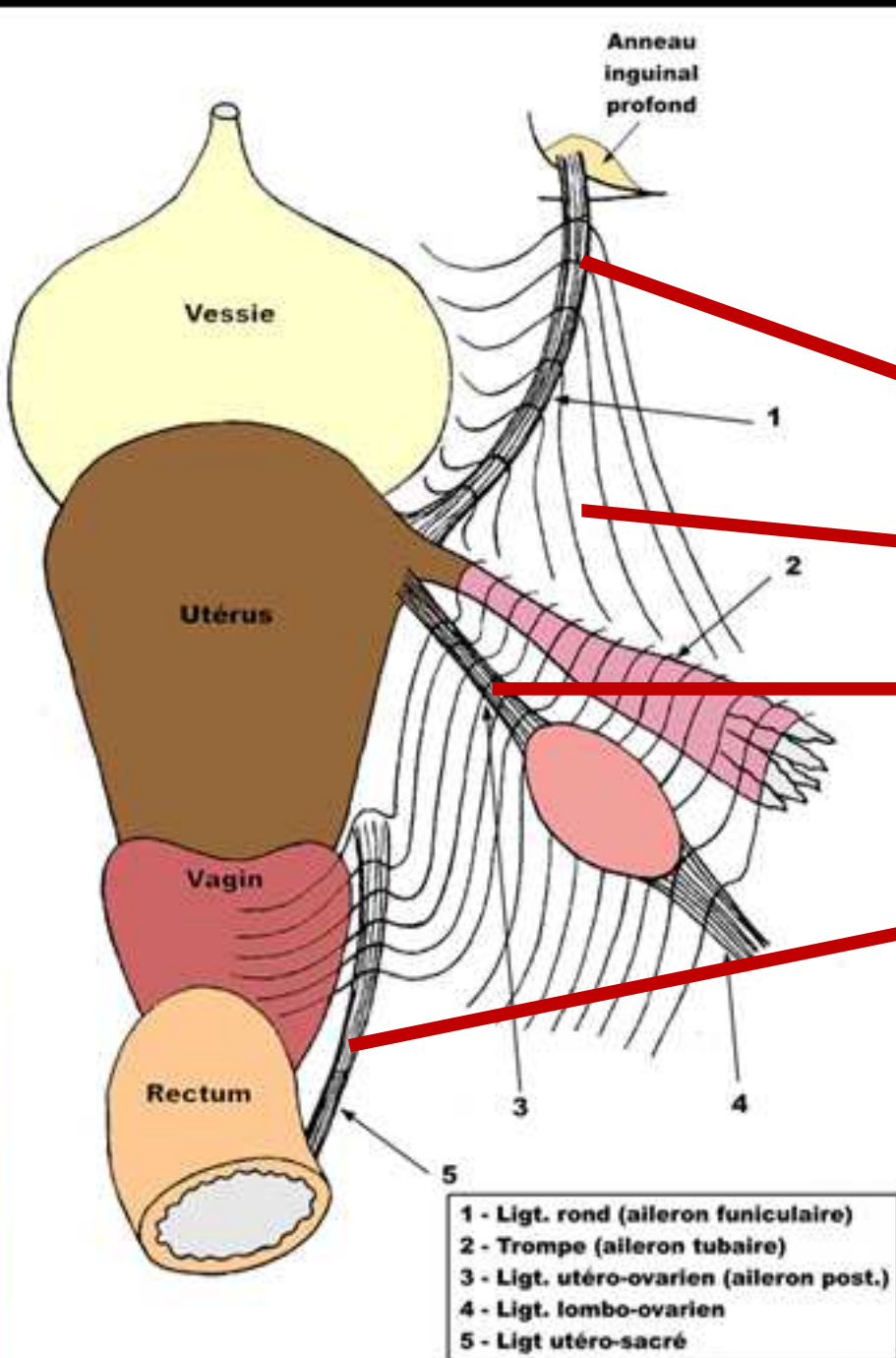
- L'utérus est rattaché aux parois du bassin par quatre paires de ligaments :

➔ Ligaments ronds..

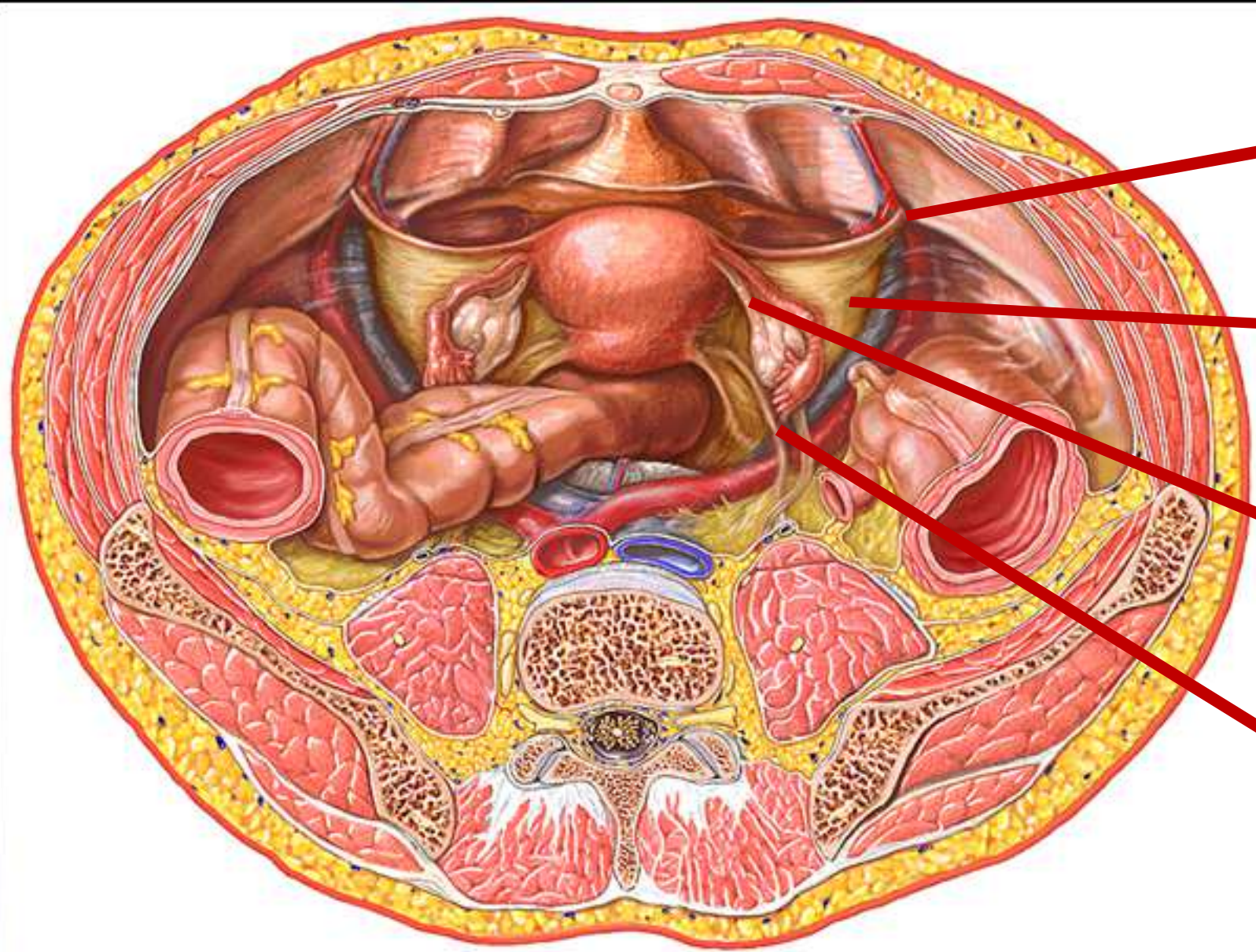
➔ Ligaments larges..

□ ➔ Ligaments utéro-ovariens.

□ ➔ Ligaments utéro-sacrés.



VUE DORSO-CRANIALE



**Ligament
rond**

Ligament large

**Ligament
utero-ovarien**

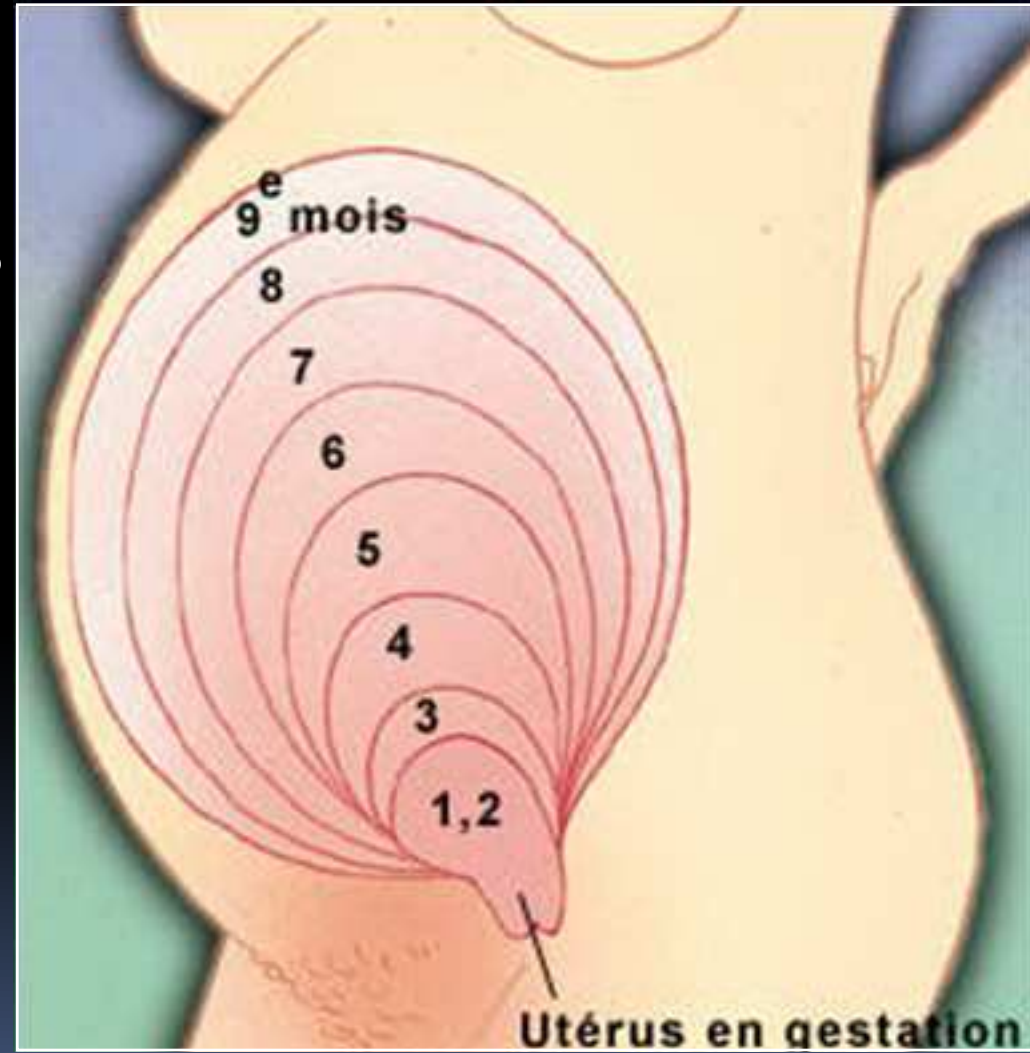
**Ligament
utero-sacré**

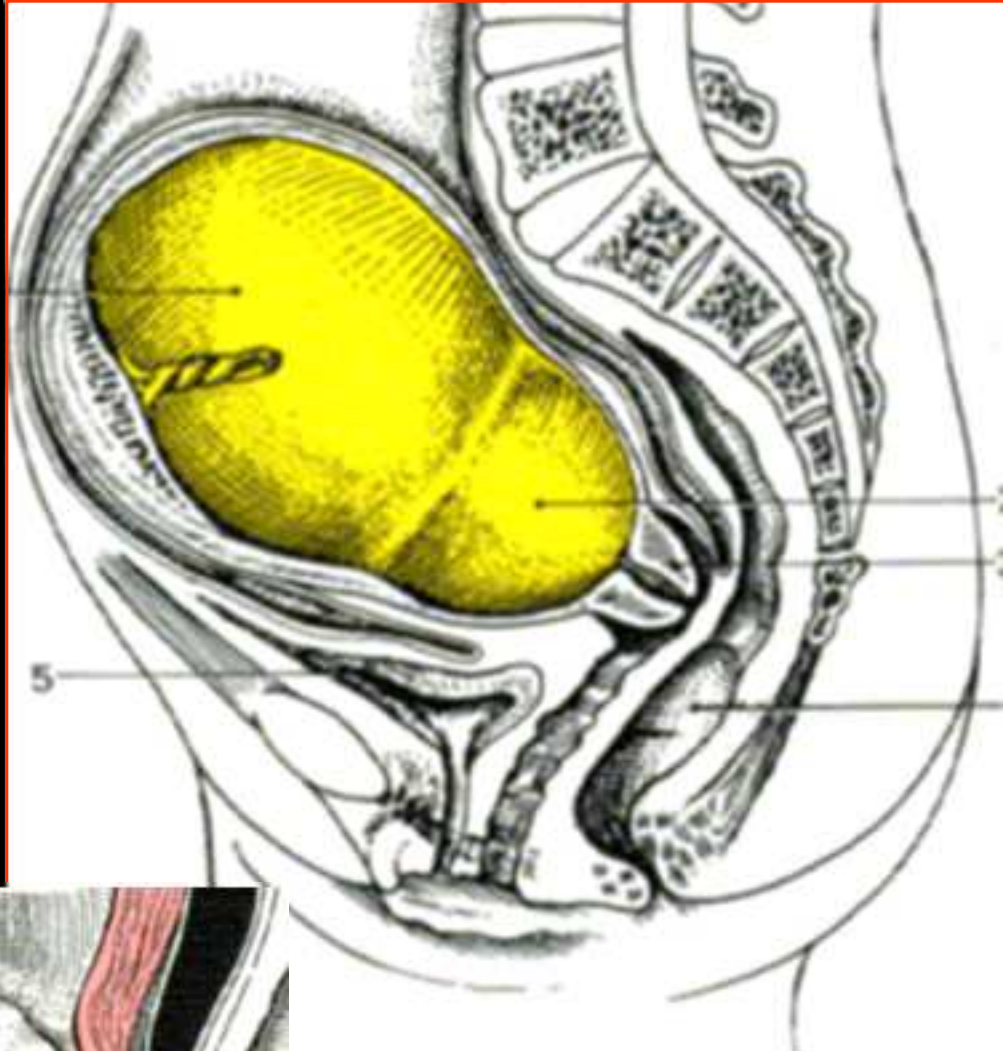
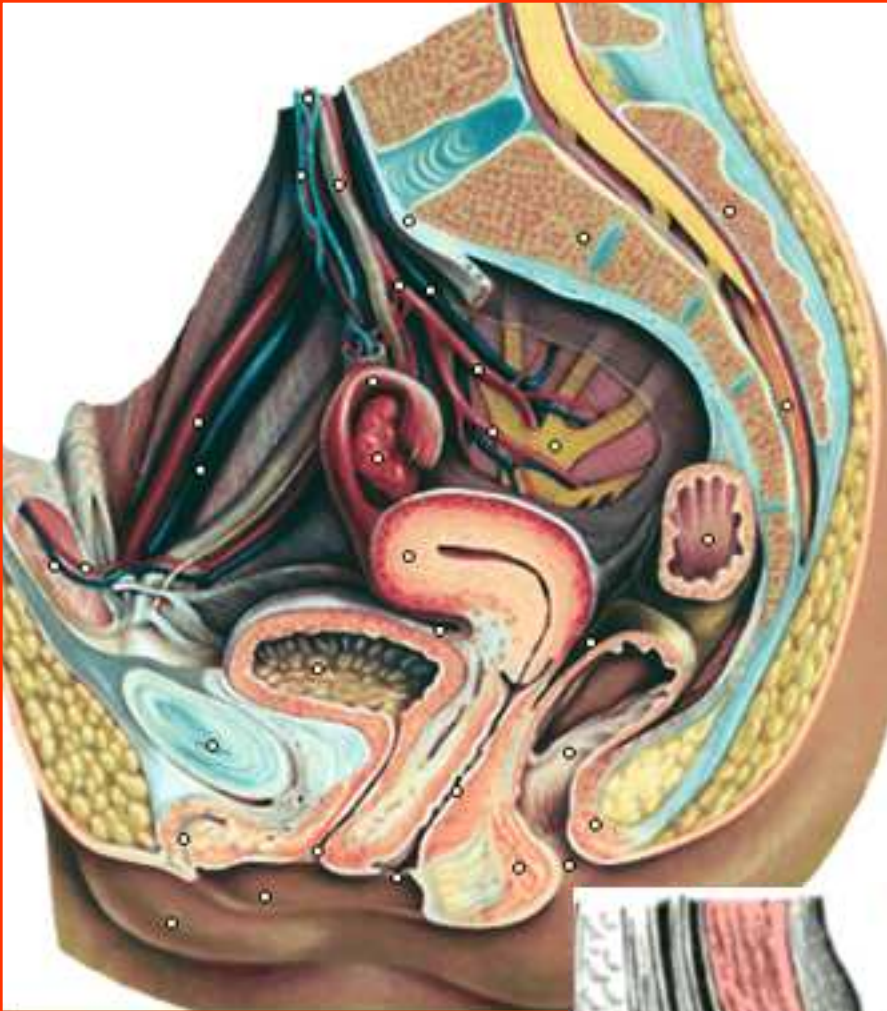


LES MODIFICATIONS DE L'UTERUS AU COURS DE LA GROSSESSE



- L'utérus gravide subit des modifications morphologiques :
 - **Situation** : il reste pelvien pendant les deux premiers mois de la grossesse puis il devient abdomino – pelvien.
 - **Forme** : jusqu'au 3ème mois il prend un aspect sphérique puis cylindrique et enfin ovoïde.
 - **La Direction** : son axe devient vertical à partir du 3ème mois.
 - **La Paroi utérine** : commence à s'amincir à partir du 3ème mois.
- Ces modifications sont évaluées par la hauteur utérine







ANNEXES DE L'UTERUS

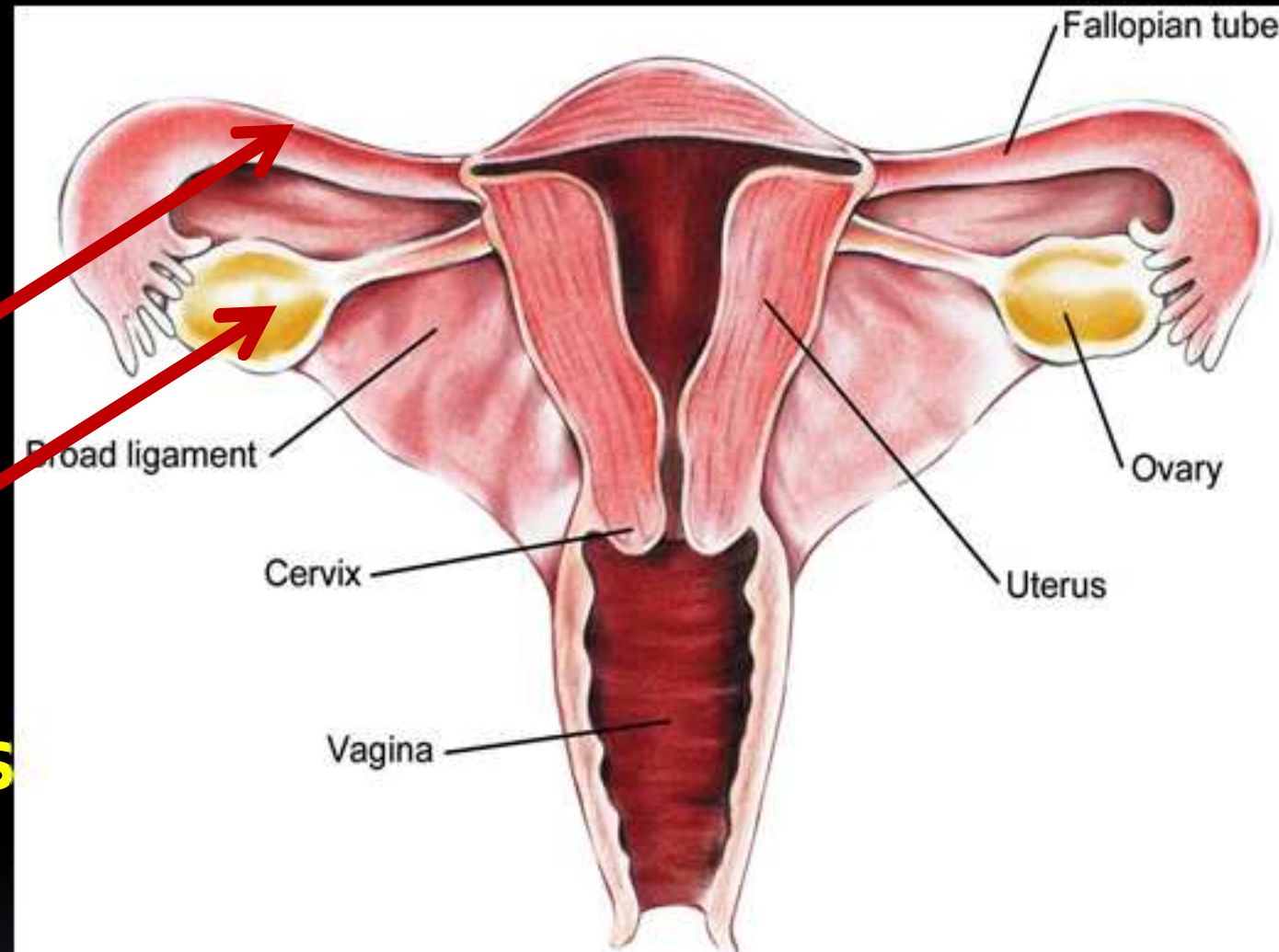


INTRODUCTION



- Les annexes de l'utérus sont représentés par:

- **La trompe utérine.**
- **L'ovaire.**
- **Leurs moyens de fixité.**

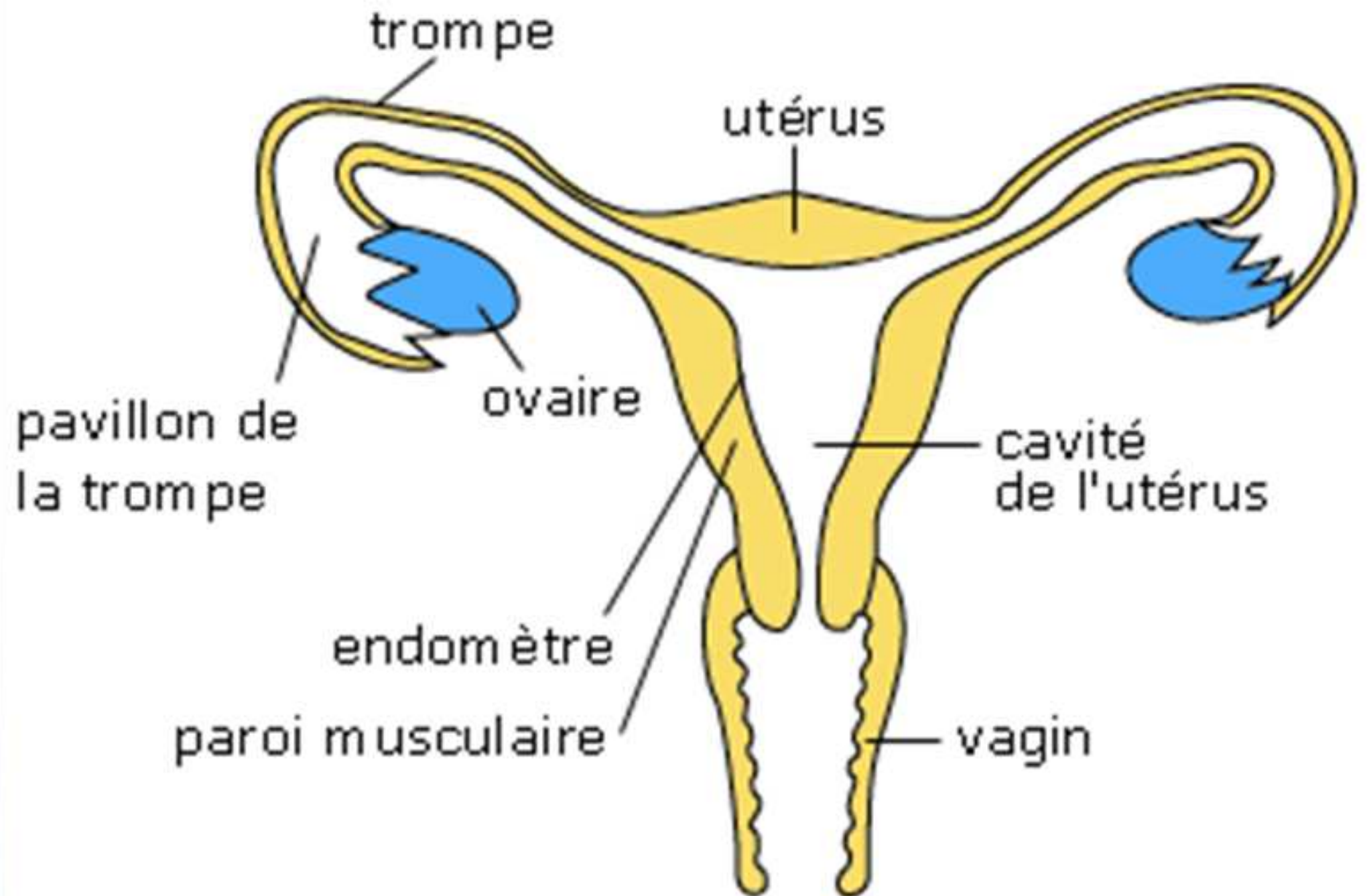




Définition

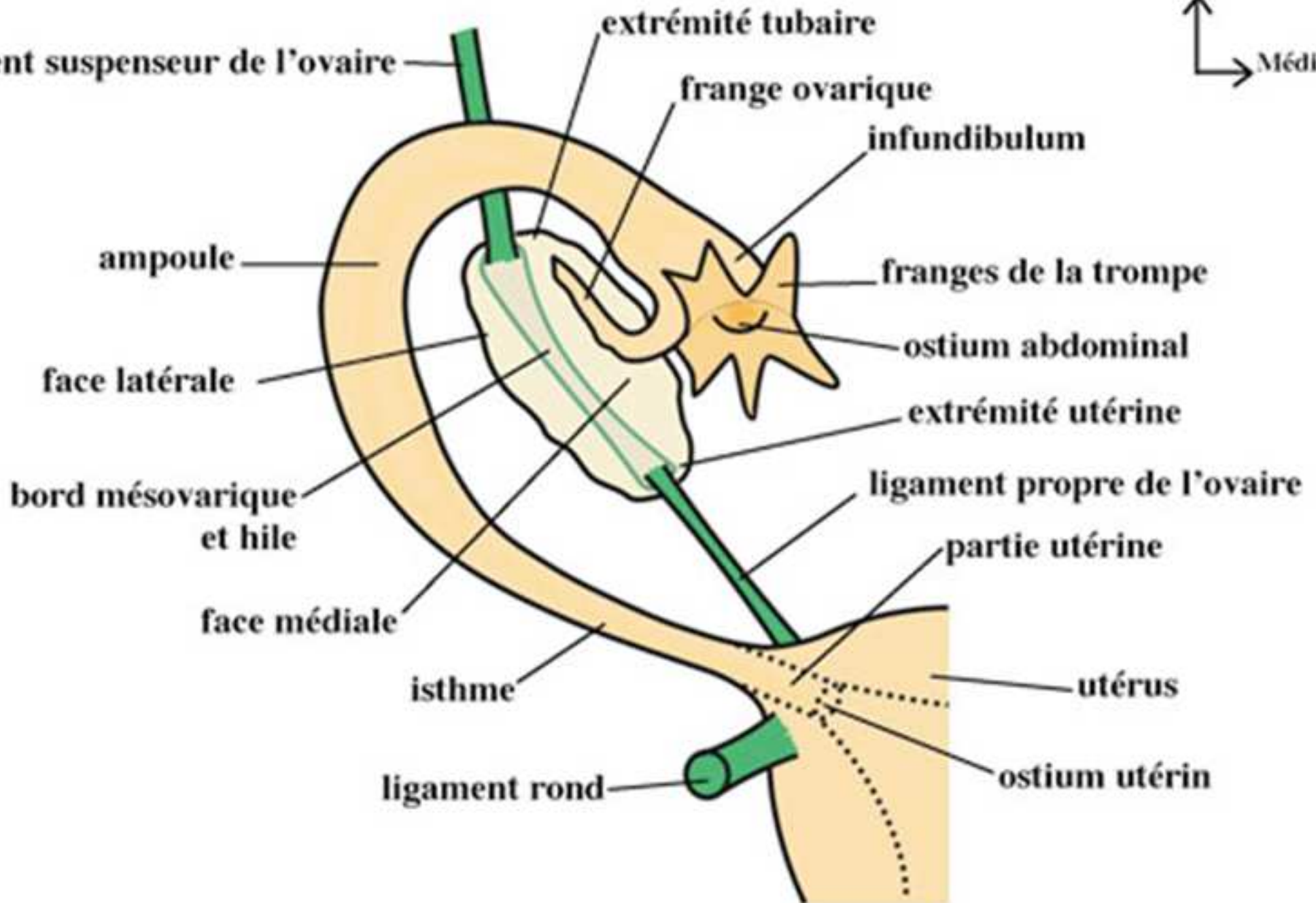
TROMPE UTERINE

- 
- La trompe utérine ou trompe de FALLOPE, lieu habituel de la fécondation,
 - C'est un conduit musculo – membraneux, pair et symétrique, qui se détache des angles droit et gauche de l'utérus pour se diriger transversalement en dehors.
 - Sa lumière fait communiquer la cavité utérine avec la cavité péritonéale. (ceci explique les grossesses péritonéales qui sont des grossesses extra-utérines)
- 



Cranial

Médial



**Ovaire et trompe utérine
(vue ventrale)**

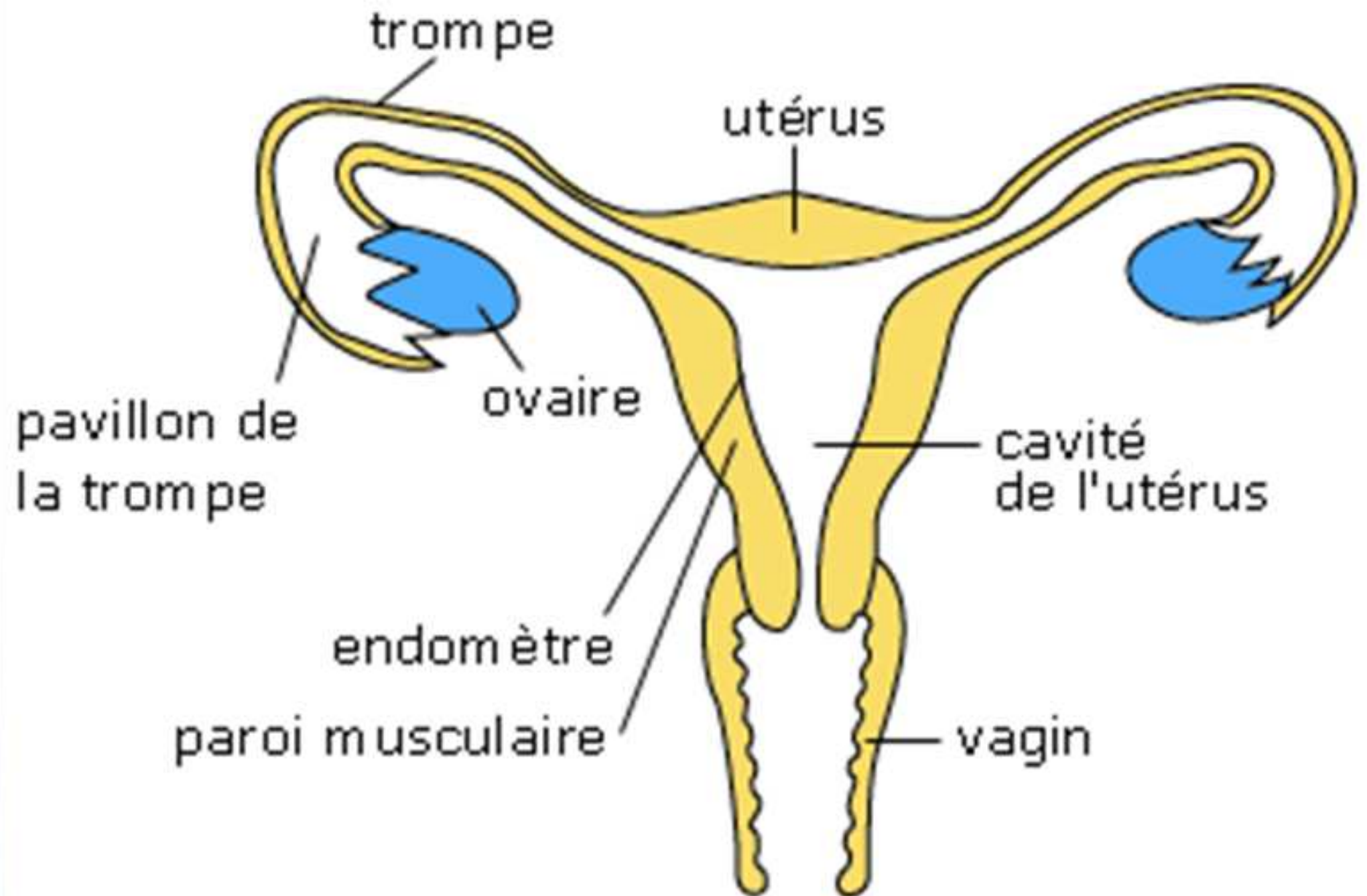


Anatomie descriptive

TROMPE UTERINE

- 
- 
- Longueur de la trompe: 10 à 12 cm,
 - Calibre : 2 – 3 mm
 - Selon le segment considéré, on lui distingue au cours d'une **hystéro. Salpingographie**, quatre segments:

- **Le segment interstitiel** : s'ouvre dans la cavité utérine par l'ostium utérinum (1 cm de longueur , 2 mm de calibre).
- **Le segment isthmique** : longueur 3 – 4 cm, calibre 2 – 4 mm.
- **Le segment ampullaire ou l'ampoule** : longueur 7 – 8 cm , calibre 7 – 8 mm.
- **Le pavillon tubaire** : c'est le segment le plus externe, il a une forme évasée en entonnoir à contours festonnés formants les franges tubaires, dont la plus longue est **la frange de RICHARD**, adhère au pôle supérieur de l'ovaire. Au fond du pavillon la lumière tubaire s'ouvre par l'ostium abdominal.



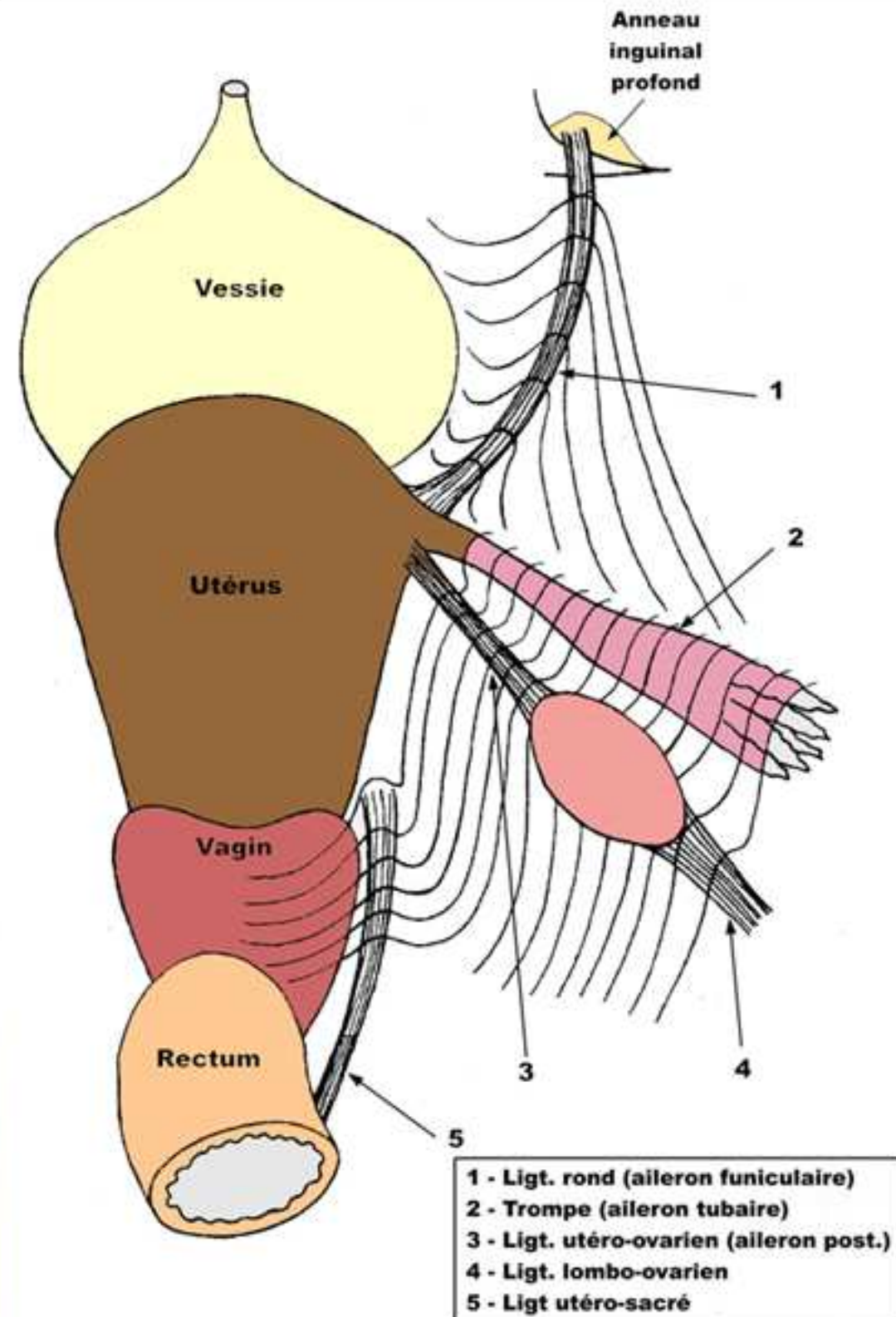


Moyens de fixité

TROMPE UTERINE

Les moyens de fixité :

- Son insertion sur la corne utérine
- Le meso – salpinx
- Le ligament tubo – ovarien : qui rattache la frange de Richard à l'ovaire.



VUE DORSO-CRANIALE



Intérêts pratiques

TROMPE UTERINE

- 
- 
- **L'ostium abdominal** qui fait communiquer la lumière tubaire avec la cavité utérine explique **les grossesses extra – utérines** abdominales parce que l'œuf fécondé tombe dans la cavité abdominale au lieu d'emprunter le chemin normal, c'est à dire de la lumière tubaire vers la cavité utérine ou il va normalement se développer

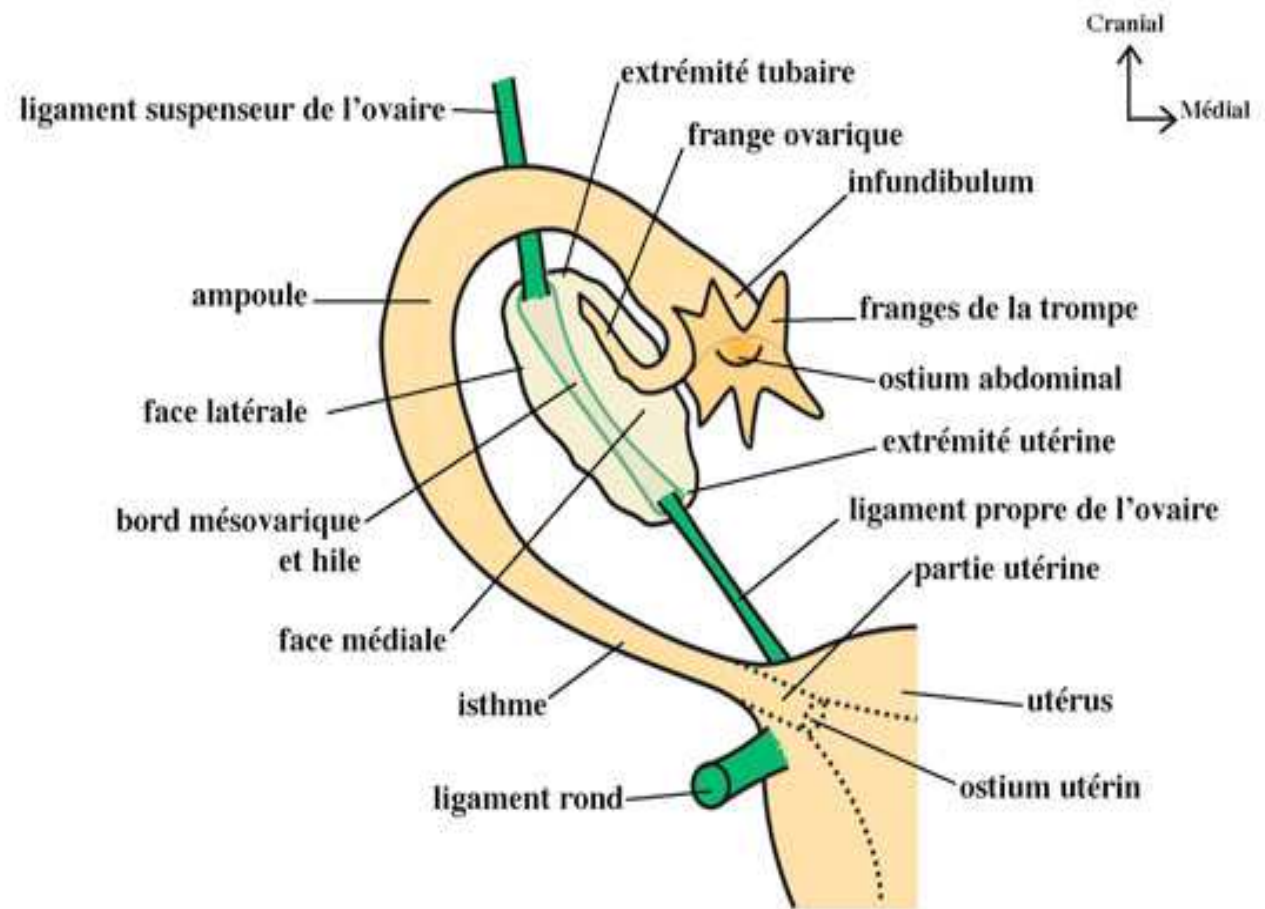


Définition

OVAIRE



- Glande génitale.
- Le lieu de formation de l'ovule.
- Le siège d'importantes sécrétion endocrines.



Ovaire et trompe utérine
(vue ventrale)

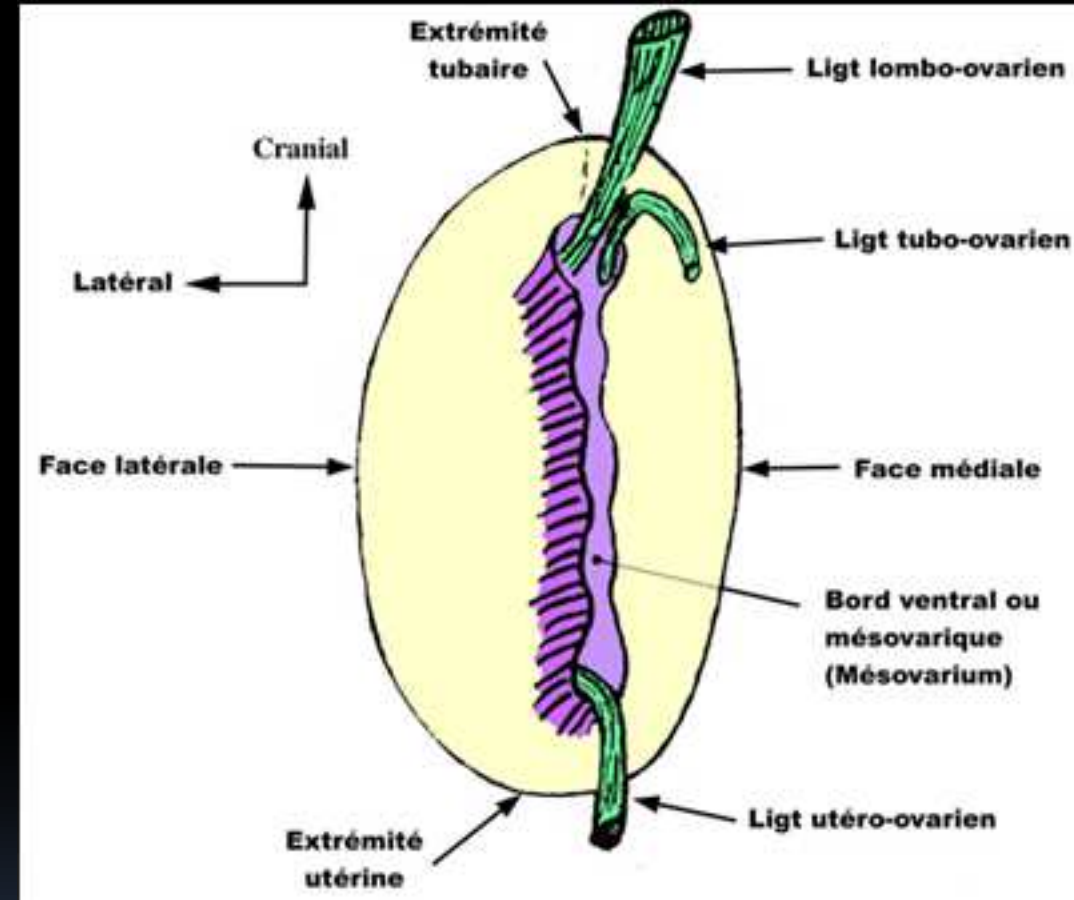


Anatomie descriptive

OVAIRE

Forme

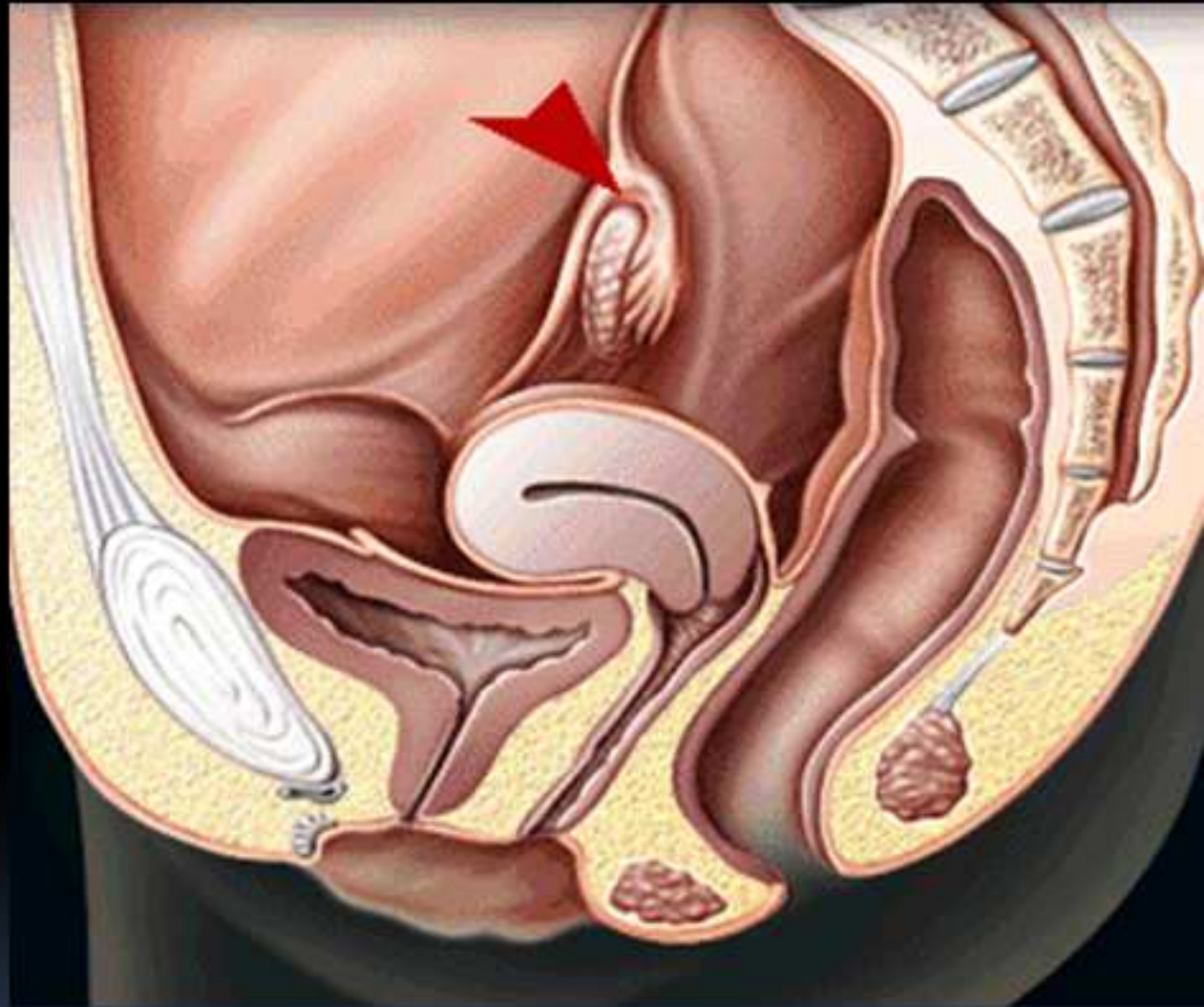
- C'est un organe pair qui présente la forme d'une **amande**.
- La **longueur 4cm**.
- La **largeur 2cm**.
- L'**épaisseur** chez la femme adulte **1cm**.
- Le **poids** de 6 – 8 g.



Situation

Organe très mobile
à situation variable
chez la nullipare
l'ovaire est situé en
arrière du ligament
large dans **la
fossette ovarienne
de KRAUSE.**

Chez la multipare il
est plus bas situé,
dans **la fossette de
CLAUDIUS.**

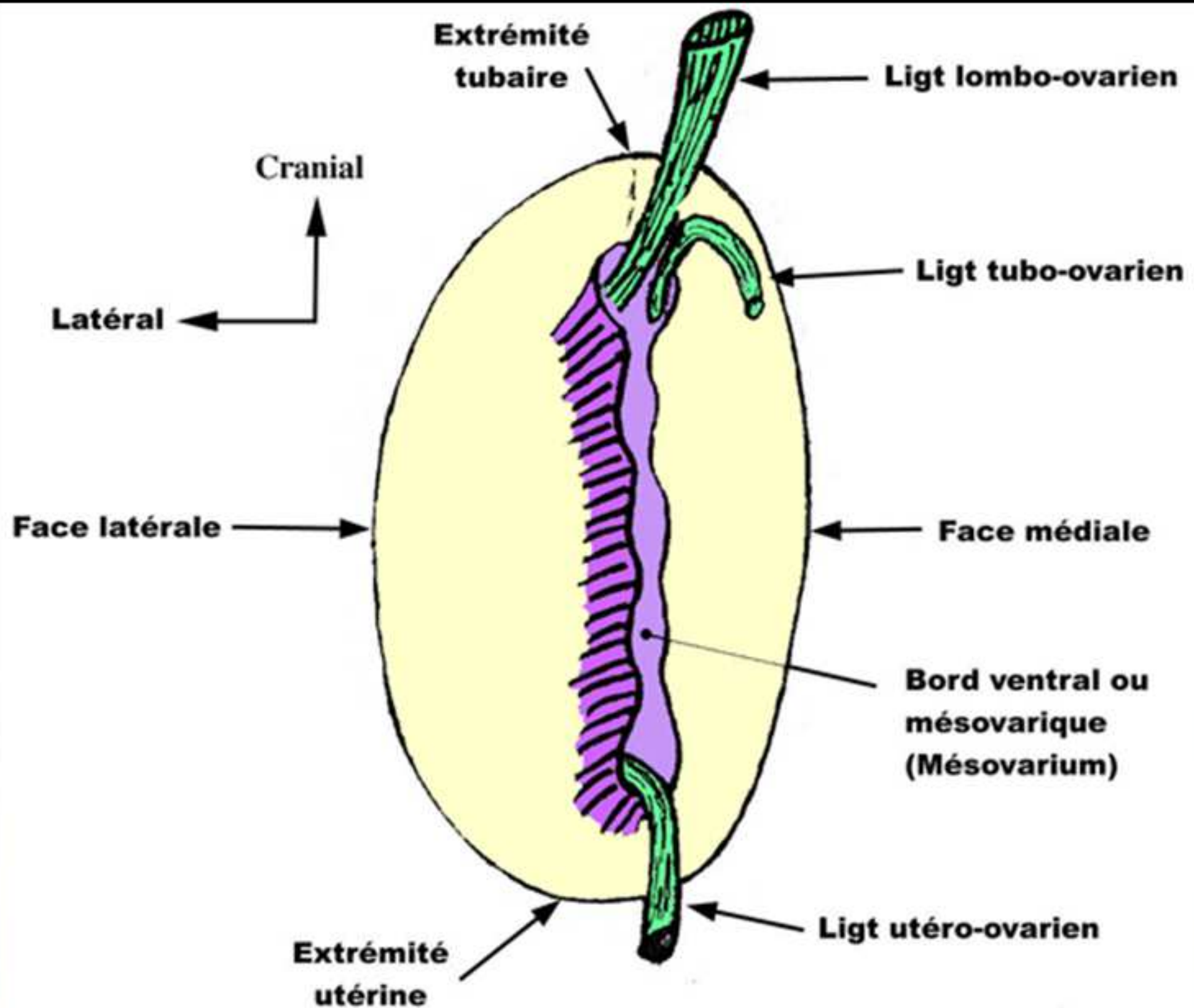


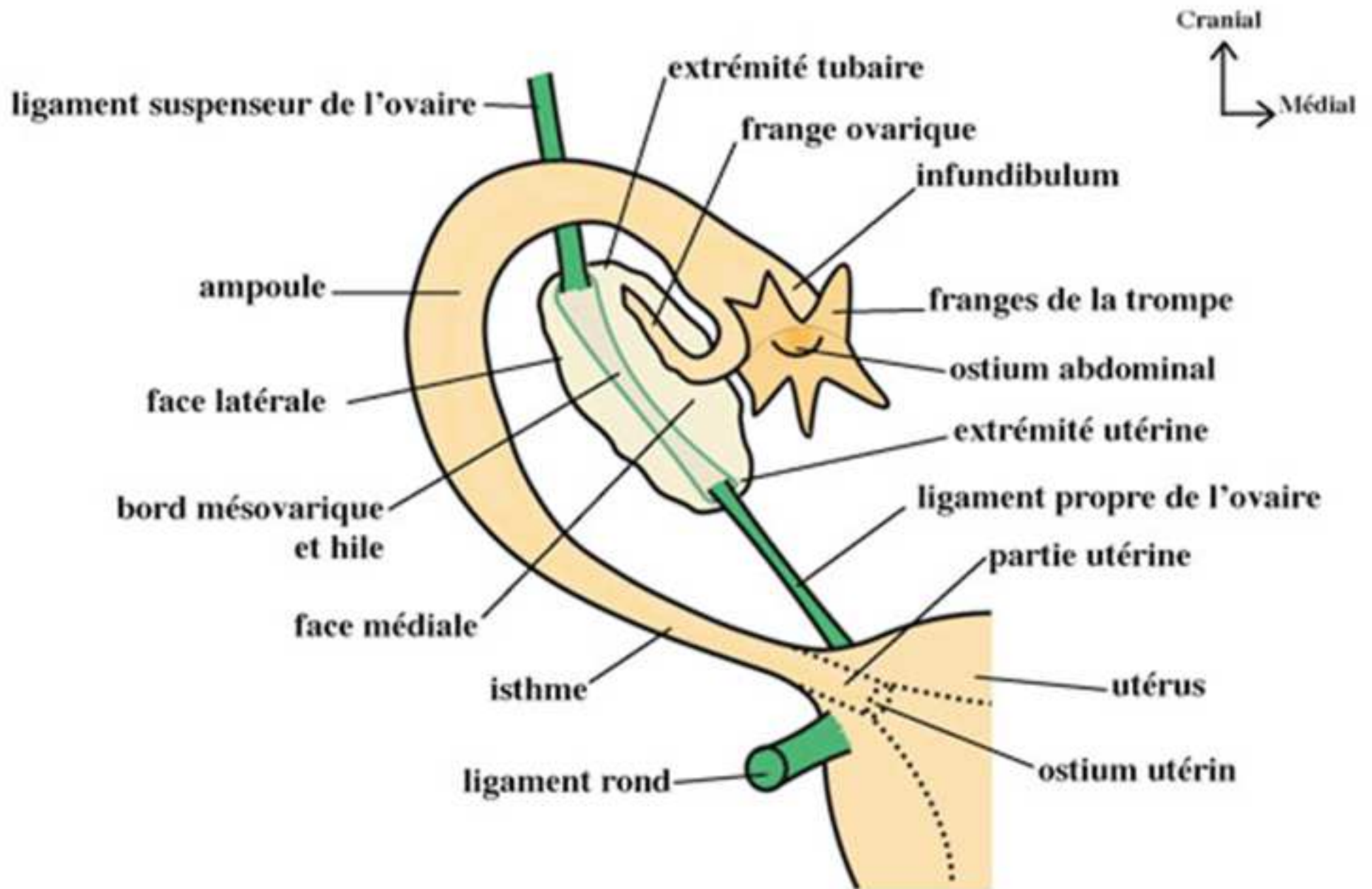


Péritoine et moyens de fixité

OVAIRE

- L'ovaire est entièrement dépourvu de péritoine, il fixé par :
 - le meso – varium
 - ligament utero – ovarien
 - ligament tubo – ovarien
 - ligament lombo – ovarien : cordon fibro – musculaire qui accompagne les vaisseaux ovariens depuis la région lombaire jusqu'au hile de l'ovaire.





**Ovaire et trompe utérine
(vue ventrale)**



Intérêts Pratiques

OVAIRE

- 
- La mobilité de l'ovaire explique la possibilité de torsion.
 - Par ailleurs l'ovaire peut se prolaber jusqu'au fond du cul de sac de Douglas, chez les grandes multipares.
 - En cas de développement d'un kyste important, l'ovaire se déplace en direction de la cavité abdominale.